

GUÍA CLÍNICA

Recursos Terapéuticos para el Duelo Infantil

40 actividades clínicas listas para la sesión

Niños de 4 a 10 años · Duelo por la pérdida de un progenitor o familiar cercano

20 recursos terapéuticos para el uso directo en sesión con niños en duelo. Cada actividad se apoya en la literatura clínica sobre duelo infantil —los modelos de Worden y Bowlby y la perspectiva de la ludoterapia— y contempla los distintos momentos del proceso: del duelo reciente a la resignificación y el cierre terapéutico.

Los recursos varían en formato (dibujo, juego, escritura, arcilla, dramatización, narrativa) y en demanda, para que el terapeuta elija y adapte según la fase, la edad y las necesidades específicas de cada niño.

Kit completo de 40 recursos (1 a 40). Cada recurso es autosuficiente; el orden es orientativo, no obligatorio.

Modelo de Worden

Teoría del apego (Bowlby)

Ludoterapia

Terapia narrativa

Índice de recursos



Cada recurso incluye objetivo, pasos de aplicación, lectura clínica, preguntas orientadoras y adaptaciones.

- 01 **La Caja de Recuerdos** — Objeto de transición y vínculo simbólico
- 02 **El Mapa de la Añoranza** — Territorios emocionales del duelo
- 03 **El Juego de los Globos** — Dejar ir sin olvidar
- 04 **Carta para Quien Se Fue** — Comunicación simbólica y despedida
- 05 **La Línea de Tiempo de la Vida Compartida** — Integrar recuerdos y ambivalencia
- 06 **El Tribunal de las Emociones** — Dar nombre a lo que pesa
- 07 **El Libro de [Nombre]** — Construir una narrativa viva
- 08 **El Termómetro del Duelo** — Monitorear el proceso
- 09 **El Juego del Antes y el Después** — Reorganización familiar tras la pérdida
- 10 **Lo que Queda Dentro de Mí** — Legado y continuidad del vínculo
- 11 **La Silla Vacía** — Conversar con quien ya no está
- 12 **El Diario de lo que Siento** — Registro semanal del duelo
- 13 **El Ritual de Buenas Noches** — Estructurar el cotidiano del duelo
- 14 **El Juego de la Verdad sobre la Muerte** — Deshacer mitos
- 15 **El Árbol de la Familia** — Quién sigue estando
- 16 **La Escultura del Duelo** — El cuerpo que siente
- 17 **La Historia que Me Cuento** — Narrativa protectora
- 18 **El Panel del Enojo** — Dar forma a lo que quema
- 19 **Conversaciones con Quien Quedó** — Orientación clínica al progenitor sobreviviente
- 20 **El Regalo del Pasado** — Cerrar un ciclo terapéutico
- 21 **El Calendario de la Añoranza** — Preparar al niño para las fechas difíciles del año
- 22 **El Puente entre Hermanos** — Trabajar el duelo compartido entre hermanos
- 23 **El Cofre de los Secretos** — El duelo que el niño guarda para no herir al adulto

- 24** **Lo que Sé y lo que Imagino** — Separar hechos de fantasías sobre la muerte
-
- 25** **El Cuerpo que Recuerda** — Mapeo somático de las sensaciones físicas del duelo
-
- 26** **La Escena que No Se Va** — Intervención para imágenes intrusivas en duelo traumático
-
- 27** **El Lugar Donde Todavía Está** — La presencia simbólica del fallecido en los espacios cotidianos
-
- 28** **La Vuelta a la Escuela** — Preparar el regreso al ambiente escolar tras la pérdida
-
- 29** **Qué Hace Dios con Esto** — Integrar creencias religiosas y espirituales al duelo
-
- 30** **La Conversación entre Hermanos** — Sesión conjunta para nombrar el duelo colectivo
-
- 31** **Cuando la Enfermedad Viene Antes** — Duelo anticipatorio durante una enfermedad prolongada
-
- 32** **El Álbum Incompleto** — Duelo de quien perdió muy temprano y tiene pocos recuerdos
-
- 33** **La Fiesta sin Él** — Resignificar celebraciones y fechas tras la pérdida
-
- 34** **Qué Hice con el Enojo Hoy** — Registro y canalización del enojo cotidiano en el duelo
-
- 35** **La Pregunta sin Respuesta** — Acoger las preguntas imposibles del duelo infantil
-
- 36** **El Amigo que También Perdió** — Identificación con pares en duelo como recurso terapéutico
-
- 37** **Cuando el Duelo Vuelve** — Preparar para las reactivaciones en fases futuras del desarrollo
-
- 38** **Qué Cambió en Mi Casa** — Nombrar y elaborar las pérdidas secundarias
-
- 39** **La Despedida que No Ocurrió** — Muertes súbitas sin posibilidad de despedida presencial
-
- 40** **Carta de la Psicóloga para el Niño** — Cierre con una carta escrita por la terapeuta como documento de identidad
-

TIPO	Actividad expresiva con un objeto concreto
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo por la pérdida de un progenitor o familiar cercano
DURACIÓN	45 a 60 minutos (puede distribuirse en 2 sesiones)
MATERIALES	Caja pequeña (de zapatos o cartón decorado), papel, marcadores, cola, fotos si la familia puede traerlas, materiales de decoración libres

Objetivo

Crear un objeto de transición concreto que le permita al niño mantener el vínculo simbólico con la persona fallecida a la vez que elabora la permanencia de la pérdida. La caja funciona como un repositorio físico de la memoria afectiva: no niega la muerte, sino que transforma el vínculo roto en algo que puede guardarse, revisitarse y resignificarse a lo largo del desarrollo. Clínicamente, la actividad permite evaluar el estadio de comprensión cognitiva del niño sobre la irreversibilidad de la muerte, identificar idealizaciones o culpas no verbalizadas y rastrear qué aspectos de la persona fallecida el niño logra preservar internamente.

Cómo aplicar

1

Presentación (5 min)

No proponga la actividad en la primera sesión: espere a que haya un espacio de confianza establecido. Muestre la caja vacía y diga algo como: «Estuve pensando en algo. A veces, cuando perdemos a alguien que queremos mucho, nos da miedo olvidarlo. Te quería proponer algo: podemos armar una caja que va a guardar todo lo que quieras recordar de esa persona. Va a ser completamente tuya». No fuerce un entusiasmo artificial. Si el niño duda, normalícelo: «No tiene que ser hoy, la podemos ir armando de a poco».

2

Decoración externa (10 min)

Invite al niño a decorar el exterior de la caja como quiera. Observe la elección de colores, la presencia o ausencia de elementos alegres, cómo la nombra (si es «la caja de papá» o «la caja de la añoranza», eso ya es material clínico). No dirija: acompañe y pregunte, con curiosidad genuina, qué está poniendo.

3

Llenado (15 a 20 min)

Ofrezca hojas en blanco y proponga que el niño escriba, dibuje o recorte cosas para poner dentro: un recuerdo favorito, algo que aprendió de la persona, algo que extraña, algo que le hubiera gustado decir. Si el niño no lee ni escribe, puede dibujar o usted puede ser el escriba. Para los más grandes (7+), proponga también una carta, sin obligación de leerla a nadie.

4

Ritual de cierre (5 min)

Cuando el niño sienta que está listo, propongan cerrar la caja juntos. Pregúntele dónde quiere guardarla en casa. Esto es importante: el lugar que elige (debajo de la cama, en un estante visible, en el cuarto de la mamá) revela mucho sobre el lugar que ocupa el duelo en el cotidiano familiar. La caja puede revisitarse en sesiones futuras, incluso como termómetro de cómo avanza el proceso.

Lectura clínica

Observe con atención qué elige poner el niño y qué deja afuera. La ausencia de ítems relacionados con la persona fallecida —cuando el niño decora la caja pero no logra llenar el interior— puede indicar dificultad de elaboración o evitación defensiva. Cuando pone cosas que «la persona necesitaría» («voy a poner una foto de su equipo para que no se olvide»), eso revela que la comprensión de la permanencia de la muerte todavía se está construyendo: no es patología, es desarrollo normal antes de los 6-7 años. Observe la afectividad durante la actividad: un niño muy acelerado, que llena la caja rápido y sin pausas, puede estar evitando el contacto con el dolor; uno que se detiene, mira el vacío y queda callado probablemente esté elaborando —no interrumpa esos silencios con preguntas inmediatas—. Preste atención a las narrativas de culpa («voy a poner acá el perdón que no pedí», «lo último que le dije fue una pelea»): son puntos que necesitan profundizarse en las sesiones siguientes.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué es lo que más extrañas de esa persona?
- ¿Hay algo que te hubiera gustado decir y no dijiste?
- ¿Qué te parece que esa persona recordaría de vos?
- ¿Hay algún olor, canción o lugar que te la recuerde?
- Cuando sientas que la extrañas, ¿qué hacés con eso?
- ¿Hay algo que aprendiste de ella que va a quedar con vos para siempre?
- Si pudieras guardar un momento dentro de esta caja, ¿cuál sería?

Adaptaciones

Para niños de 4 a 6 años: simplifique el llenado —use solo dibujos y deje que el niño narre mientras dibuja—. Usted registra por escrito debajo de cada dibujo lo que él dice.

Para niños resistentes: no fuerce el llenado. Proponga que la caja quede vacía por ahora y que ponga una cosa por semana. Eso crea un ritual semanal de acceso al duelo sin sobrecargar.

Para niños que perdieron al progenitor en circunstancias traumáticas (muerte violenta, suicidio): evite preguntas sobre el momento de la muerte. Enfóquese en el antes, en los recuerdos anteriores al evento. La elaboración del trauma de la muerte es trabajo de una etapa posterior.

Para niños que niegan la muerte: no confronte directamente. Permita que pongan en la caja lo que quieran. La negación es una protección necesaria; el proceso irá abriendo espacio para la realidad a medida que el vínculo terapéutico sostenga el contacto con el dolor.

TIPO	Actividad proyectiva con dibujo y narrativa
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo por la pérdida de un progenitor, abuelos o persona de referencia
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja grande (A3 si es posible), marcadores o lápices de colores, lapicera para el terapeuta

Objetivo

Mapear los territorios emocionales del niño en relación con el duelo —qué emociones están presentes, cuáles se están evitando, dónde se siente seguro y dónde siente dolor— mediante un recurso visual espacializado. El «mapa» como metáfora cumple dos funciones: externaliza el mundo interno del niño de forma menos amenazante que la pregunta directa, y crea un documento visual que puede revisitarse en sesiones futuras como termómetro del proceso. La actividad favorece el acceso a contenidos que el niño no logra nombrar verbalmente pero sí ubicar espacialmente —especialmente útil para niños que responden «no sé» a las preguntas emocionales directas—.

Cómo aplicar

1

Presentación (3 min)

Coloque la hoja grande sobre la mesa y diga: «¿Viste alguna vez un mapa? Los mapas muestran lugares. Pero podemos hacer un mapa distinto: un mapa de los sentimientos. Quiero que dibujes un mapa de todo lo que sentís cuando pensás en [nombre]. Puede tener lugares, caminos, colores, lo que quieras. No hay bien ni mal». Si el niño pide ayuda, diga que pueden hacerlo juntos y pregunte: «¿Por dónde empezamos?».

2

Construcción libre (20 a 25 min)

Acompañe al niño mientras dibuja, con preguntas abiertas sobre lo que va construyendo. No interprete en voz alta: solo refleje de vuelta —«Esta zona de acá, ¿qué es?» o «Contame sobre este lugar»—. Observe la distribución espacial: qué está en el centro, qué en los bordes, qué está separado, qué está rodeado de barreras. Si el niño hace solo un dibujo sin estructura de mapa, acéptelo: lo que produzca es el material.

3

Nombramiento (10 min)

Al final, proponga que el niño nombre las regiones del mapa. Puede ofrecer palabras como sugerencia («esto de acá, ¿parece un lugar de alegría o de tristeza?»), pero deje que el niño confirme o corrija. Escriba los nombres en las regiones según él indique. Al cerrar, pregunte: «¿Hay alguna parte del mapa que visitás bastante? ¿Y alguna que evitás?».

4

Guardado del mapa (2 min)

Guarde el mapa en la carpeta del niño en el consultorio. En las sesiones siguientes, proponga revisitarlo: «Mirá el mapa que hicimos. ¿Cambió algo? ¿Hay algún lugar nuevo?». Esto convierte el recurso en un instrumento longitudinal de evaluación del proceso de duelo.

Lectura clínica

La estructura espacial del mapa es, en sí misma, diagnóstica. Los niños que concentran todo el mapa en torno a la persona fallecida —sin espacio para elementos de la vida actual— pueden estar en un duelo que todavía no permite invertir en nuevas relaciones. Los que crean un mapa con muchos lugares alegres y «esconden» la tristeza en un rincón pequeño pueden estar en negación o recibiendo del ambiente familiar el mensaje implícito de que no está permitido sufrir. Atención especial a las «regiones prohibidas» —áreas que el niño delimita pero no quiere nombrar, o que describe como «peligrosas», «oscuras» o «adonde no se puede ir»—: suelen encubrir culpa, enojo con el fallecido o contenidos ligados a las circunstancias de la muerte. No fuerce la entrada: registre y espere a que el proceso cree un espacio seguro. Observe también la presencia o ausencia del niño en su propio mapa: cuando se incluye como personaje o lugar, hay mayor integración del self en el duelo; su ausencia puede indicar disociación del sufrimiento o la sensación de no tener lugar en esa pérdida.

Preguntas orientadoras

- Contame sobre este lugar de acá: ¿qué pasa en él?
- ¿Hay algún lugar del mapa que te guste visitar? ¿Por qué?
- ¿Hay alguno que evites? ¿Qué hay ahí?
- Si la añoranza fuera un lugar del mapa, ¿cómo sería?
- Y el enojo, ¿tendría un lugar en este mapa?
- Mirando el mapa entero, ¿qué sentís?
- Si pudieras cambiar algo del mapa, ¿qué cambiarías?

Adaptaciones

Para niños más pequeños (5-6 años): reemplace la propuesta de «mapa» por «la casa de los sentimientos» —cada ambiente tiene un sentimiento—. Es más concreto y accesible.

Para niños muy verbales y resistentes al dibujo: haga el mapa en forma de lista o descripción oral —usted escribe y el niño dicta los lugares—. Lo importante es la espacialización del contenido.

Para el niño que dice «no sé dibujar»: ofrezca formas geométricas simples —círculos, cuadrados, líneas—. Dígale que el mapa no tiene que ser lindo, solo verdadero.

TIPO	Dinámica terapéutica con metáfora y movimiento
EDAD	4 a 8 años
DEMANDA	Duelo con negación, dificultad para aceptar la permanencia de la muerte
DURACIÓN	30 a 40 minutos
MATERIALES	Globos (no hace falta inflarlos de verdad: pueden representarse con bollos de papel), papelitos, lapicera, hilo

Objetivo

Trabajar concretamente la tensión central del duelo infantil: el niño necesita, a la vez, aceptar que la persona no volverá y mantener el vínculo interno con ella. Este recurso usa la metáfora del globo para externalizar ese proceso: el globo sube, desaparece de la vista, pero el hilo que el niño sostiene representa el recuerdo que permanece. No es un recurso de «cierre» del duelo, sino una forma de mostrar que mantener y dejar ir no son opuestos. Especialmente útil con niños que repiten conductas de espera (se quedan en la ventana esperando el regreso, se niegan a redistribuir las pertenencias, mantienen el lugar en la mesa).

Cómo aplicar

1

Preparación e introducción (5 min)

Siéntese en el piso con el niño. Muestre los materiales y explique: «Hoy vamos a hacer algo distinto. Quiero que pensemos en las cosas que sentimos cuando alguien que queremos se va. Cada cosa que escribamos va a quedar en un papelito chiquito». Si el niño no escribe, usted escribe mientras él habla.

2

Escritura de los contenidos (10 min)

Proponga tres tipos de papeles: (1) cosas que el niño extraña —se escriben y se atan con hilo a un «globo» de papel (un bollo)—; (2) cosas que le recuerdan a la persona —quedan guardadas en el bolsillo o en su mano—; (3) cosas pesadas que el niño carga y que lo cansan —escritas aparte—. No fuerce la separación entre categorías: deje que el niño guíe.

3

La metáfora del globo (10 min)

Tome los «globos» (bollos de papel) con las cosas que pesan. Sostenga el hilo y pídale al niño que suelte el bollo: «se va», pero el hilo queda. Diga: «Mirá, el bollo se fue, pero el hilo sigue acá. Así es con los recuerdos: la persona se fue, pero lo que sentimos no se va con ella». Deje que el niño suelte y sostenga el hilo las veces que quiera. No apure.

4

Lo que queda (5 min)

Pregunte qué quiere hacer el niño con los papeles de los recuerdos —los que quedaron en la mano—. Algunos van a querer llevarlos a casa; otros, ponerlos en la caja de recuerdos (si ya se hizo). Siga al niño.

Lectura clínica

Observe la reticencia del niño a soltar el globo. Si lo sostiene con fuerza y no quiere soltarlo, no fuerce: ese es el material. Diga: «No hace falta soltarlo hoy. Podemos solo sostenerlo un poquito». La resistencia a soltar representa defensas legítimas que necesitan sostén antes del movimiento. Si el niño suelta el globo muy rápido y sin afecto, investigue: puede ser evitación emocional o duelo inhibido. Pregunte: «¿Qué sentiste cuando lo soltaste?». Si la respuesta es un «nada» dicho con liviandad, merece profundizarse. Atención a qué categoría elige para cada cosa: los niños que ponen en «cosas pesadas» afectos como el amor o la añoranza (en lugar del enojo o la culpa) pueden estar señalando que el propio vínculo emocional se vive como una carga, lo que indica investigar el ambiente familiar y los mensajes que el niño recibe sobre cómo comportarse frente a la pérdida.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué sentís cuando pensás en dejar ir el globo?
- ¿Te parece que recordar es distinto de no poder soltar?
- ¿Qué querés guardar con vos para siempre?
- ¿Hay algo que sentís que pesa mucho y que te gustaría poner en el globo?
- Cuando sostenés el hilo, ¿qué estás sosteniendo?
- ¿Te parece que se puede guardar a una persona dentro del corazón sin que esté acá?

Adaptaciones

Para niños de 4 a 5 años: use la versión literal con un globo real e inflenlo juntos en la sesión. La experiencia sensorial del globo —liviano, que sube— refuerza la metáfora de forma más vívida y accesible al pensamiento concreto.

Para duelo por suicidio o muerte violenta: no use esta actividad en las primeras sesiones. Antes de trabajar el «soltar», el niño necesita haber elaborado mínimamente el trauma de la forma de la muerte. La metáfora del globo funciona cuando hay algún nivel de integración de la realidad de la pérdida, no antes.

Para niños con duelo cronificado (más de 2 años sin movimiento en el proceso): agregue una etapa en la que el niño describa cómo era la vida antes de la pérdida y cómo es ahora. El contraste entre ambos momentos puede abrir la conciencia de que el tiempo pasó y de que es posible moverse.

TIPO	Actividad de expresión escrita y verbal — biblioterapia aplicada
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Duelo con culpa, despedidas no hechas, muerte súbita o inesperada
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Papel especial (de color o con bordes decorados), lapiceras de colores, sobre

Objetivo

Crear un espacio de comunicación simbólica con la persona fallecida para que el niño pueda decir lo que quedó sin decir: palabras de amor, pedidos de perdón, preguntas sin respuesta, enojo, añoranza. La carta no necesita leerse a nadie. El acto de escribir tiene función de elaboración independiente de su lectura posterior. Para niños que perdieron al progenitor en una muerte súbita o accidental —sin posibilidad de despedida— esta actividad ofrece lo que el evento real negó: un momento de cierre y de expresión. La carta también sirve para trabajar la culpa infantil: el niño que cree que peleó con el padre «y por eso murió» puede, a través de la carta, revisitar y resignificar esa creencia.

Cómo aplicar

1

Creación del contexto (5 min)

Antes de proponer la carta, tenga una conversación breve sobre comunicación y pérdida. Pregunte: «¿Alguna vez te quedaste sin poder decirle algo a alguien que querías mucho?». No dirija hacia la persona fallecida de inmediato: deje que el niño llegue. Si no llega, ofrezca: «A veces, cuando perdemos a alguien, nos quedan cosas adentro que no tuvieron tiempo de salir. Te quería proponer algo: ¿y si escribimos una carta?».

2

Escritura de la carta (20 a 25 min)

Ofrezca el papel especial y aclare que la carta es completamente privada —usted no la va a leer sin permiso—. Proponga que empiece como quiera: por el nombre de la persona, por «hola», por «te quería contar...». Si el niño se traba, ofrezca una estructura de apoyo: (1) Lo que más extraño es...; (2) Algo que me hubiera gustado decirte es...; (3) Quiero que sepas que...; (4) Ahora que te fuiste, yo voy a... No todas: deje que el niño elija por cuál empezar.

3

Lectura y procesamiento (10 min)

Cuando termine, pregunte si quiere compartir alguna parte con usted, sin presión. Si quiere leer, escuche sin interpretar de inmediato. Después de leer, pregunte: «¿Cómo estás ahora? ¿Qué sentiste mientras escribías?». Priorice el procesamiento afectivo antes que cualquier contenido cognitivo.

4

Destino de la carta (5 min)

Pregunte qué quiere hacer con la carta: guardarla en el sobre, ponerla en la caja de recuerdos, llevarla a casa, dejarla en el consultorio. Algunos van a querer «mandarla de verdad»; para eso, puede proponer un ritual: ponerla en el sobre, dirigirla al cielo (o adonde el niño cree que está la persona) y, en sesión, hacer un acto simbólico de entrega. Respete la creencia religiosa de la familia.

Lectura clínica

Atención al tono de la carta. Una carta excesivamente formal y «perfecta» —sin rastro de emoción— puede indicar que el niño todavía no tiene acceso seguro al afecto ligado a la pérdida, o que está escribiendo lo que cree que el terapeuta quiere leer. Aliente la autenticidad: «Puede ser desprolija. Puede ser enojo también. La carta no tiene que ser linda, tiene que ser verdadera». Observe la presencia de culpa explícita o implícita. Cuando el niño escribe «perdón» o «tendría que haber sido mejor», no reestructure cognitivamente de inmediato. Primero acoja: «Venís cargando esto hace tiempo...». La elaboración de la culpa precede a la disputa cognitiva de la creencia. Los niños que escriben cartas llenas de enojo explícito («¿por qué te fuiste?», «me dejaste») están en un proceso sano de reconocimiento del abandono y necesitan que ese enojo sea validado, no silenciado. El enojo con el fallecido es normal y clínicamente importante de acoger.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay algo que quisieras mucho haberle dicho a esa persona?
- Si pudieras hablar con ella cinco minutos ahora, ¿qué le dirías?
- ¿Hay algo que quedó inconcluso entre ustedes dos?
- ¿Sentís que ella sabía cuánto la querías?
- ¿Hay algo que sientas que necesita un perdón, de tu parte o de la de ella?
- ¿Qué te parece que ella te diría si pudiera responder esta carta?

Adaptaciones

Para niños que no escriben: reemplace la carta por una grabación de audio. El niño le habla al celular (o grabador) como si estuviera llamando a la persona. El audio puede guardarse o borrarse: la elección es suya.

Para niños que rechazan la actividad: no fuerce. Proponga que escriban la carta de un personaje ficticio que perdió a alguien. La distancia del personaje puede ser el espacio seguro que necesitan para acceder al contenido.

Para duelo por suicidio: la actividad es especialmente potente pero exige cautela. El niño puede cargar una culpa devastadora («si hubiera hecho algo distinto...»). Asegúrese de que haya sostén terapéutico establecido antes de proponerla y esté preparado para una sesión de gran intensidad afectiva.

TIPO	Actividad de reconstrucción narrativa e integración de recuerdos
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Duelo con idealizaciones extremas o con enojo y ambivalencia hacia la persona fallecida
DURACIÓN	50 a 60 minutos (puede dividirse en 2 sesiones)
MATERIALES	Hojas pegadas en secuencia (formando una tira larga) o papel kraft, marcadores, cola, fotos opcionales

Objetivo

Construir una narrativa integrada de la relación con la persona fallecida —que incluya tanto momentos alegres como momentos de conflicto, distancia o dolor— para que el niño pueda elaborar el duelo desde una representación más realista y humanizada. La idealización excesiva de la persona muerta es un fenómeno común y comprensible, pero clínicamente puede dificultar el duelo al crear una imagen irreal que el niño no logra integrar. Del mismo modo, los niños con relaciones ambivalentes (padre ausente, madre que peleaba mucho) suelen cargar culpa y confusión porque sienten que no deberían enojarse con alguien que murió. La línea de tiempo ofrece un soporte concreto para contener la ambivalencia: lo bueno y lo difícil pueden coexistir en el mismo papel.

Cómo aplicar

1

Armado físico (5 min)

Pegue las hojas formando una tira horizontal larga (al menos 60 cm). Colóquela frente al niño. Explique: «Vamos a hacer una línea de tiempo. ¿Sabés qué es? Es como un camino que muestra todo lo que pasó, del principio hasta ahora. Vamos a hacer la línea de tiempo de tu vida con [nombre]». Marque a la izquierda el nacimiento del niño y a la derecha el momento actual.

2

Llenado (25 a 30 min)

Pida que el niño vaya colocando momentos a lo largo de la línea, del pasado al presente. No dirija hacia lo positivo o lo negativo: acepte lo que venga. Para cada momento, pregunte qué estaba sintiendo. Observe si logra colocar momentos de conflicto, distancia o dolor, o si produce solo una línea idealizada. Si solo aparecen momentos positivos, no confronte: pregunte con cuidado: «¿Había algún momento que era más difícil? Toda relación los tiene, ¿no?».

3

El punto de la pérdida (5 min)

Cuando lleguen al momento de la muerte, no lo saltee. Márquelo en la línea junto al niño. Pregunte: «¿Cómo fue ese día para vos?» y «¿Qué cambió después de ese momento?». El niño puede continuar la línea más allá de la muerte —cómo fue la vida después— o querer parar ahí. Respete el momento de detención.

Lectura de la línea (5 min)

Miren juntos la línea entera. Pregunte: «Mirando todo esto, ¿qué notás?» y «¿Qué parte no querés olvidar nunca?». Guarde la línea en el consultorio: puede retomarse en sesiones futuras como documento vivo del proceso.

Lectura clínica

Observe la densidad de la línea. Los niños que producen líneas muy escasas, con pocos eventos, pueden tener una memoria afectiva empobrecida de la relación (ausencia física del fallecido, relación distante) o estar en un proceso de borramiento defensivo. Investigue cuál de las dos hipótesis se ajusta mejor a la historia contada por la familia. Las líneas con «saltos» —períodos que el niño saltea sin nombrar— merecen atención: esos silencios suelen corresponder a períodos de conflicto familiar, enfermedad, separación de los padres u otros eventos que el niño no sabe cómo insertar en la narrativa del duelo. No fuerce el nombramiento: registre para profundizar después. Cuando el niño pone un solo punto en la línea (el momento de la muerte) y no logra construir nada antes ni después, eso señala que el trauma de la muerte está sobreponiéndose a la totalidad de la relación: la muerte tomó el lugar de la vida que hubo antes. Es un signo importante de duelo complicado que requiere atención.

Preguntas orientadoras

- ¿Cuál es el momento que más te gusta recordar?
- ¿Había algún momento que era más difícil entre ustedes dos?
- Si pudieras ponerle un olor, una música o un color a ese momento de la línea, ¿qué sería?
- ¿Hay algún período de la línea que preferirías que no hubiera pasado?
- Mirando la línea entera, ¿cómo describirías a esa persona para alguien que nunca la conoció?
- ¿Qué te parece que era lo que esa persona más quería de vos?

Adaptaciones

Para niños que perdieron al progenitor muy temprano (antes de los 3 años): adapte la actividad para incluir también historias contadas por la familia. El niño puede poner en la línea «cosas que me contaron» y «cosas que yo recuerdo», una distinción importante para que comprenda cómo construye la imagen de la persona.

Para relaciones de abandono previo a la muerte (padre que se fue de casa y después falleció): incluya en la línea tanto el período de convivencia como el de ausencia. No trate la ausencia como algo neutro: pregunte qué sentía el niño durante ese tiempo.

Para niños muy pequeños que no logran construir la línea solos: usted puede iniciar colocando hitos que la familia relató, y el niño va confirmando, corrigiendo o agregando lo que sabe.

TIPO	Juego de cartas con categorización emocional
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo con dificultad de nombramiento emocional, duelo inhibido, niño que responde «estoy bien» a todo
DURACIÓN	35 a 45 minutos
MATERIALES	Cartas con nombres de emociones (una por carta: añoranza, enojo, miedo, alivio, culpa, amor, confusión, celos, soledad, vergüenza, tristeza, alegría, ansiedad, paz), tres cajitas o zonas en la mesa: «siento esto», «nunca siento esto», «a veces siento esto»

Objetivo

Ampliar el vocabulario emocional del niño en relación con el duelo, rompiendo la barrera del «estoy bien» o del «no sé» que suele bloquear el acceso al proceso terapéutico. Muchos niños en duelo no tienen dificultad para sentir, sino para nombrar. Otros reciben mensajes implícitos del ambiente de que ciertas emociones están prohibidas respecto de la persona muerta (especialmente el enojo y el alivio). El formato de juego con cartas quita el peso de la pregunta directa y permite que el niño acceda a contenidos que no accedería por preguntas abiertas. Incluir emociones «socialmente prohibidas» en el duelo —como el alivio (sobre todo cuando había conflicto o enfermedad prolongada) y los celos— es clínicamente fundamental.

Cómo aplicar

1

Armado del juego (3 min)

Organice las tres zonas en la mesa: «Siento esto», «A veces siento», «Nunca siento» —con hojas de color o cajitas—. Mezcle las cartas de emoción. Explique: «Vamos a jugar. Yo te voy a dar una carta por vez con el nombre de un sentimiento. Vos la vas a poner en uno de los tres lugares, pensando en cómo te estás sintiendo desde que [nombre] se fue. No hay respuesta correcta ni incorrecta. Podés decir lo que quieras».

2

Distribución de las cartas (15 a 20 min)

Entregue una carta por vez. Para cada carta que el niño ponga en «siento esto» o «a veces siento», haga una pregunta breve de profundización: «Contame un momento en que sentiste esto». No lo haga con todas: elija las que parecen más cargadas afectivamente. Para las de «nunca siento», acoja sin confrontar, pero registre mentalmente: a veces lo que el niño rechaza más rápido es lo que más lo activa.

3

La carta sorpresa (5 min)

Al final, agregue una última carta en blanco y diga: «Esta carta está vacía. Si pudieras escribir el nombre de un sentimiento que no apareció en ninguna otra, ¿cuál pondrías?». Suele ser la emoción más significativa de la sesión.

Visión general (5 min)

Miren juntos las cartas distribuidas. Pregunte: «De todo lo que quedó en el grupo “siento esto”, ¿cuál es la más pesada?» y «¿Cuál preferirías no sentir?». Esto crea una jerarquía clínica para las próximas sesiones.

Lectura clínica

Atención especial a las cartas de «alivio» y «enojo». Cuando el niño las pone rápido en «nunca siento» o se ríe nervioso al leerlas, puede indicar que recibió un mensaje —explícito o implícito— de que esas emociones están prohibidas respecto de la persona muerta. El alivio es especialmente común y silenciado en familias donde hubo enfermedad prolongada, conflicto conyugal intenso o una figura parental abusiva. Cuando el niño pone «culpa» en «siento esto» sin pausar ni mostrar afecto, puede estar tan habituado a cargar esa culpa que se volvió parte de su identidad; es distinto de cuando pone «culpa», se detiene, mira la carta y queda callado —en ese segundo caso hay algo vivo que merece profundización inmediata—. Observe también la dinámica corporal: los niños que aceleran y distribuyen las cartas sin parar pueden estar evitando el contacto real con el contenido. En ese caso, proponga desacelerar: «Esperá un poco en esta. Contame más de ella».

Preguntas orientadoras

- ¿Sabías que se podía sentir esto cuando alguien muere? ¿Alguien te dijo que estaba permitido?
- ¿Cuál de estas cartas fue la más difícil de ubicar en algún lugar?
- ¿Hay algún sentimiento que te parece que no deberías sentir, pero lo sentís?
- ¿Hay alguien con quien hablás de estas cosas que estás sintiendo?
- Cuando sentís [emoción elegida], ¿qué hacés con eso?
- Si [nombre] viera estas cartas, ¿qué te parece que diría?

Adaptaciones

Para niños de 4 a 6 años: reemplace los nombres escritos por caritas que expresen cada emoción (impresas o dibujadas). El formato pictórico es más accesible para prelectores.

Para niños muy intelectualizados que categorizan todo rápido: agregue una ronda en la que deban hacer un gesto o sonido que represente cada emoción antes de ubicarla. El componente corporal rompe la defensa cognitiva.

Para uso con la familia (progenitor sobreviviente presente): puede hacer el juego por separado con el niño y con el adulto, y después comparar los resultados juntos; eso favorece la comunicación sobre el duelo dentro de la familia.

TIPO	Proyecto terapéutico de larga duración — construcción de un libro artesanal
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo por muerte súbita, duelo con riesgo de borramiento de la memoria del fallecido, niño que perdió al progenitor muy temprano
DURACIÓN	Proyecto de varias sesiones (4 a 8 encuentros de 30 a 40 min cada uno)
MATERIALES	Cuaderno u hojas abrochadas formando un librito, fotos (las trae la familia), materiales de decoración, marcadores, cola

Objetivo

Construir, a lo largo de varias sesiones, un libro de vida sobre la persona fallecida —escrito e ilustrado por el niño— que cumpla tres funciones clínicas a la vez: (1) preservar la memoria de forma concreta y accesible; (2) darle al niño un rol activo en el duelo —no es pasivo ante la pérdida, es el narrador—; (3) integrar la información sobre la persona que el niño recibió de terceros con la que vivió directamente. Este recurso está especialmente indicado cuando hay riesgo de borramiento de la figura del fallecido por parte del ambiente familiar: familias que no hablan del muerto, que retiran las fotos de la casa, que intentan «seguir adelante» sin espacio para el duelo.

Cómo aplicar

1

Sesión 1 — Presentación y estructura del libro (30 min)

Presente el proyecto como algo especial: «Te quiero proponer algo que va a llevar algunas sesiones. Vamos a hacer un libro sobre [nombre]. Un libro de verdad, escrito y dibujado por vos». Arme la estructura del librito junto al niño: decidan cuántas páginas, el título, la tapa. La tapa ya es material clínico: ¿cómo quiere el niño presentar a esa persona al mundo?

2

Sesiones 2 a 6 — Páginas temáticas

Cada sesión trabaja una sección del libro. Sugerencias: (1) «Quién era [nombre]»: descripción física y de personalidad; (2) «Las cosas que hacíamos juntos»: recuerdos de actividades compartidas; (3) «Lo que aprendí de él/ella»: legado afectivo y práctico; (4) «Algo difícil que recuerdo»: espacio para la ambivalencia y los recuerdos de conflicto; (5) «Lo que siento cuando lo/la recuerdo»: página de expresión emocional libre; (6) «Lo que quiero que la gente sepa de él/ella»: cómo quiere el niño que sea recordado.

3

Última sesión — Cierre y ritual (30 min)

Lean el libro juntos de principio a fin. Pregunte al niño si quiere agregar algo. Proponga un ritual de cierre: firmar como autor, poner una dedicatoria. Conversen dónde va a quedar el libro —en casa o en el consultorio—. Muchos niños piden llevarlo a casa y mostrárselo al familiar sobreviviente: puede ser un momento terapéutico importante para la familia.

Lectura clínica

Observe cómo decide el niño organizar el contenido de cada página. La sección «algo difícil que recuerdo» suele ser la más reveladora, y la que más se resiste a llenar. La resistencia a incluir cualquier aspecto negativo o difícil del fallecido es un indicador de idealización protectora. En ese caso no confronte: diga «toda relación tiene momentos más difíciles, es parte de ser humano» y deje la elección al niño. El libro funciona también como termómetro del apoyo familiar: los niños cuyas familias hablan abiertamente del fallecido llegan a las sesiones con más historias y más detalles; los de familias silenciosas llegan con páginas en blanco, lo que indica necesidad de trabajo paralelo con el progenitor sobreviviente. La sección «lo que quiero que la gente sepa» es particularmente importante para niños que sienten que el fallecido fue borrado o mal comprendido por la familia o el entorno social: ese espacio de autoría le devuelve al niño el poder de definir la narrativa sobre quién fue.

Preguntas orientadoras

- Si alguien que nunca conoció a [nombre] leyera este libro, ¿qué te gustaría que sintiera?
- ¿Hay alguna historia que no podés poner acá porque no te alcanzan las palabras?
- ¿Qué página fue la más difícil de hacer? ¿Por qué?
- ¿Hay alguien a quien te gustaría que leyera este libro?
- Haciendo este libro, ¿descubriste algo que no sabías antes?

Adaptaciones

Para niños que perdieron al progenitor antes de los 3 años (memoria muy limitada): incluya una sesión en la que invite a un familiar a participar y contar historias que el niño no vivió directamente. El niño ilustra mientras el adulto narra: cocreación intergeneracional del libro.

Para niños muy resistentes al trabajo formal de duelo: mantenga el formato de libro pero cambie la propuesta —en lugar de un libro sobre el fallecido, «un libro sobre mí y [nombre]»—. La centralidad del niño en la narrativa reduce la amenaza del contacto con la pérdida.

TIPO	Instrumento de monitoreo clínico con formato lúdico
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Uso longitudinal a lo largo del acompañamiento — aplicar al inicio, a la mitad y al final del proceso
DURACIÓN	15 a 20 minutos por aplicación
MATERIALES	Hoja con un termómetro dibujado (escala de 0 a 10 con zonas de color), preparada antes de la sesión

Objetivo

Ofrecer al niño un instrumento visual y concreto de automonitoreo del proceso de duelo, que a la vez funciona como herramienta de evaluación clínica longitudinal para el terapeuta. El termómetro externaliza un proceso que es, por naturaleza, interno y difuso, permitiendo que el niño desarrolle metacognición sobre sus propios estados afectivos. Al aplicarse repetidamente a lo largo del acompañamiento, genera un registro del movimiento (o el estancamiento) del proceso. Clínicamente, es también un instrumento de comunicación con la familia: los resultados pueden compartirse con el progenitor sobreviviente para facilitar la conversación sobre el duelo en casa.

Cómo aplicar

1

Preparación de la hoja (antes de la sesión)

Dibuje o imprima un termómetro grande con escala de 0 a 10. Defina las zonas con colores: 0 a 3 = azul oscuro («el dolor está muy presente»); 4 a 6 = amarillo («hay días buenos y días difíciles»); 7 a 10 = verde («me estoy sintiendo más liviano»). Deje espacio para que el niño escriba o dibuje al lado de cada zona.

2

Aplicación con el niño (15 min)

Explique: «Este es un termómetro, pero no es para medir la fiebre. Es para medir cómo te estás sintiendo por dentro, en relación con la añoranza y el dolor de no tener más a [nombre]. El 0 sería si el dolor fuera muy fuerte, tan fuerte que cuesta hacer cualquier cosa. El 10 sería si sintieras que estás bien, que el dolor dio un espacio. ¿Dónde estás hoy?». Después de que marque el número, explore: «¿Por qué elegiste ese número y no uno mayor (o menor)?» y «¿Qué tendría que pasar para subir un número?». Al reaplicarlo en sesiones futuras, compare los resultados frente al niño: «Mirá, la sesión pasada estabas en el 4. Hoy marcaste 6. ¿Qué cambió?». Ese movimiento de comparación es clínicamente poderoso: el niño ve concretamente que el proceso se está moviendo.

Lectura clínica

Cuando el niño marca números muy altos (8, 9, 10) en las primeras sesiones tras la pérdida, puede indicar negación o anestesia emocional, no recuperación. Pregunte: «¿Cómo te sentís cuando pensás en él/ella ahora?». Si el afecto no se corresponde con el número alto, el termómetro se está usando de forma defensiva. Cuando los números quedan estancados durante muchas semanas —siempre el mismo—, es señal de duelo complicado o de un ambiente que no permite el movimiento. Investigue el contexto familiar: ¿se habla de la añoranza en casa?, ¿el progenitor sobreviviente está disponible emocionalmente? Cuando el niño se niega a marcar cualquier número —dice «no sé» o lo deja en blanco—, eso no es una falla de la actividad: es dato clínico. Significa que todavía no tiene acceso suficiente a sus estados internos para diferenciarlos en una escala. En ese caso, trabaje primero los recursos de nombramiento emocional (como el Tribunal de las Emociones) antes de volver al termómetro.

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué ese número y no uno más o uno menos?
- ¿Cómo estuvo la semana en relación con ese número?
- ¿Qué pasó que te hizo subir (o bajar) respecto de la última vez?
- ¿Qué te parece que tendría que pasar para sentirte un número más liviano?
- ¿Hay algún momento de la semana en que el número es distinto, más pesado o más liviano?

Adaptaciones

Para niños a los que no les gustan los números: reemplace la escala numérica por tamaños de nube —nube pequeña (dolor leve), nube mediana, nube de tormenta (dolor muy intenso)—. La metáfora de la nube que pasa es en sí misma terapéutica.

Para uso en una sesión de devolución con la familia: presente el termómetro como un gráfico de cómo se fue sintiendo el niño a lo largo de las sesiones (con su autorización). Esto facilita la conversación entre el progenitor y el niño sobre el proceso en casa.

TIPO	Juego guiado con narrativa y miniaturas
EDAD	4 a 8 años
DEMANDA	Duelo reciente, niño con dificultad para comprender la permanencia de la muerte, reorganización familiar tras la pérdida
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Miniaturas de caja de arena (familia, casa, personajes), bandeja de arena si está disponible; alternativa: hoja grande dividida en dos campos y miniaturas sobre ella

Objetivo

Trabajar la reorganización simbólica de la estructura familiar tras la pérdida, usando el juego como lenguaje primario de elaboración. La división entre «antes» y «después» no busca oponer los dos momentos, sino que el niño pueda reconocer que la familia cambió, y que ese cambio puede nombrarse, representarse y, eventualmente, integrarse. El uso de miniaturas da una distancia simbólica segura: el niño puede mover a la «familia de juguete» sin tener que hablar directamente de la propia. Esto es especialmente importante para niños que se disocian de su propio duelo cuando se los interroga de forma directa.

Cómo aplicar

1

Armado del campo (5 min)

Divida la mesa (o bandeja de arena) en dos campos: «Antes» y «Después». Si no hay bandeja, use una hoja grande A2 dividida por una línea. Ponga a disposición las miniaturas. Explique: «Vamos a jugar con este campo. Acá es el antes —cómo era antes—. Acá es el después —cómo es ahora—. Vos elegís qué va en cada lugar».

2

Campo del «Antes» (15 min)

Pida que el niño arme el campo del antes, usando las miniaturas para representar la familia, la casa, las cosas que existían. No dirija. Observe quién es colocado dónde, las cercanías y distancias entre las figuras, qué se excluye. Haga preguntas abiertas: «¿Quién es este? ¿Dónde queda?». Registre mentalmente la configuración.

3

Campo del «Después» (15 min)

Ahora pida que arme el campo del después, con cómo están las cosas ahora. Observe los cambios respecto del antes: quién salió, quién quedó, quién cambió de lugar. La persona fallecida puede aparecer de formas inesperadas en el después: como miniatura todavía presente, como una ausencia marcada por un espacio vacío, o como un elemento que el niño busca pero no encuentra entre las miniaturas. Todo eso es material clínico.

Comparación y narrativa (10 min)

Muestre los dos campos lado a lado y pregunte: «¿Qué cambió?». Deje que el niño compare. Pregunte: «¿Cómo te sentís mirando el después?» y «¿Hay algo del antes que te gustaría traer al después?». Si el niño quiere reorganizar el campo del después de otra forma, déjelo. La reorganización simbólica es, en sí misma, el acto terapéutico.

Lectura clínica

Observe la posición de la persona fallecida en el campo del «después». Los niños que todavía la colocan ahí («sigue acá porque está en el cielo») están elaborando la permanencia de la muerte de forma consistente con el desarrollo —para menores de 7 años, es esperable—. En niños más grandes, esa representación puede indicar que la comprensión de la irreversibilidad aún está incompleta o que la familia sostiene una narrativa que dificulta la elaboración. Observe cómo se representa el niño a sí mismo en ambos campos: cuando pone su propia miniatura muy periférica, aislada o ausente en el después, señala una experiencia de marginación en el duelo familiar —el niño que siente que el duelo de los adultos excluyó al suyo—. La presencia de nuevos elementos en el después que no estaban en el antes (nueva pareja del progenitor sobreviviente, casa nueva, nuevos hermanos) es material clínico rico sobre cómo procesa el niño los múltiples cambios simultáneos que suelen acompañar la muerte de un progenitor.

Preguntas orientadoras

- ¿Quién es cada uno acá en el campo? Presentame a la familia.
- ¿Qué cambió de un campo al otro?
- ¿Hay alguien que estaba en el antes y extrañaste en el después?
- ¿Cómo te sentís mirando el campo del después?
- Si pudieras cambiar algo del campo del después, ¿qué cambiarías?
- ¿Hay algún lugar donde [nombre] todavía está presente en el campo del después?

Adaptaciones

Para niños sin acceso a miniaturas (contextos con pocos recursos): reemplace por dibujo. Divida la hoja en dos campos y el niño dibuja las dos escenas. El principio y la lectura clínica son los mismos.

Para niños en una reorganización familiar compleja (nueva pareja, mudanza, escuela nueva): agregue un tercer campo —«lo que imagino para el futuro»— creando una tríada temporal que trabaja la proyección y la esperanza además de la elaboración de la pérdida.

Para niños con buena conciencia de la muerte: puede nombrar explícitamente que el campo del después es «cómo es la familia sin [nombre]», sin metáforas. Con comprensión cognitiva más avanzada, el nombramiento directo es más respetuoso que la protección simbólica excesiva.

TIPO	Actividad de dibujo proyectivo con narrativa guiada
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Fase de resignificación del duelo — cuando el niño ya tiene alguna elaboración y necesita trabajar la continuidad del vínculo con el fallecido
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja A4 con una silueta humana dibujada (que representa al niño), marcadores de colores

Objetivo

Trabajar la cuarta tarea del duelo propuesta por Worden —encontrar una forma de mantener la conexión con la persona fallecida mientras se embarca en una nueva fase de vida— de manera concreta, visual y accesible. La actividad parte del principio de que el duelo sano no exige abandonar el vínculo con el muerto, sino transformarlo: de una relación de presencia física a una de presencia interna. La silueta del niño llena con elementos de la persona fallecida es una externalización poderosa de ese proceso interno. Está indicada para niños que ya atravesaron la aceptación de la permanencia de la muerte y están en la fase en que el duelo empieza a ceder espacio para la reinversión en la vida, y que a veces sienten culpa por eso.

Cómo aplicar

1

Presentación (5 min)

Entregue la hoja con la silueta y explique: «Esta silueta sos vos. Te quiero proponer algo: sabemos que [nombre] se fue. Pero algunas cosas que él/ella tenía quedan dentro nuestro, las llevamos sin darnos cuenta. Quiero que pienses y dibujes, dentro de la silueta, todo lo que quedó de [nombre] dentro tuyo». Dé ejemplos concretos si hace falta: «puede ser algo que enseñaba, una forma de ser, una palabra que siempre escuchabas, un olor que recordás...».

2

Llenado (20 a 25 min)

El niño llena la silueta con palabras, dibujos, colores o símbolos que representen lo que «quedó» del fallecido dentro suyo. No dirija. Acompañe con interés genuino. Pregunte por cada elemento que agrega: «Contame de esto». La ubicación dentro de la silueta también es significativa: qué queda en el corazón, qué en la cabeza, qué en las manos.

3

Fuera de la silueta (5 min)

Cuando el niño termine el interior, proponga que también ponga afuera las cosas del fallecido que no quiere cargar —no como rechazo, sino como distinción de lo que es suyo y lo que era del otro—. Esa diferenciación es clínicamente importante: los niños en duelo a veces internalizan no solo los aspectos positivos, sino también los patrones problemáticos del fallecido.

4

Narrativa y cierre (10 min)

Pida que el niño «lea» lo que hay dentro de la silueta. Escuche con atención qué eligió cargar. Cierre con: «Todo esto que está dentro de la silueta es parte de vos ahora, y también es una forma de que [nombre] siga presente». Si surge la emoción, sostenga el silencio.

Lectura clínica

Observe la proporción entre lo que hay dentro y lo que hay fuera de la silueta. Un niño que pone todo dentro —sin nada afuera— puede estar en un proceso de fusión con el fallecido que dificulta la individuación. Pregunte: «¿Hay algo que era solo de él/ella y que no hace falta que sea tuyo?». Una silueta vacía —un niño que no logra identificar nada que haya quedado del fallecido dentro suyo— puede indicar empobrecimiento del vínculo antes de la muerte (relación distante o ausente) o bloqueo de acceso a la memoria afectiva. No interprete directamente: pregunte «¿Hay algo que hacés hoy y que tiene alguna relación con [nombre]?». A veces el legado está en las acciones, no en los recuerdos conscientes. La presencia de elementos negativos dentro de la silueta («su enojo», «cómo gritaba») es muy relevante: no la minimice. Pregunte: «¿Querés cargar esto o querés ponerlo afuera?». Eso le da al niño agencia sobre lo que internaliza, y esa agencia es parte de la elaboración sana del duelo.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay algo que hacés hoy que aprendiste de él/ella?
- ¿Hay algo que, cuando lo hacés, te hace pensar en él/ella?
- ¿Te parece que cargás algo de su forma de ser?
- ¿Hay algo que no querés cargar, algo que era muy de él/ella pero que no hace falta que sea tuyo?
- Mirando lo que hay dentro de la silueta, ¿cómo te sentís?
- ¿Te parece que se puede estar bien y aun así cargar la añoranza?
- ¿Qué te parece que a él/ella le hubiera gustado dejarte?

Adaptaciones

Para niños que perdieron al progenitor muy temprano (antes de los 3 años): trabaje el legado a partir de lo que cuenta la familia —«¿qué dicen las personas que heredaste de él/ella?»—. El recurso se transforma en una actividad de construcción de identidad narrativa basada en las historias de otros.

Para niños con culpa por sentirse bien: la frase de cierre es especialmente importante. Normalice explícitamente: «Sentirte bien no significa que estés olvidando. Podés estar feliz y a la vez querer y extrañar. Las dos cosas pueden existir juntas».

Para niños que inician una nueva etapa de vida (escuela, hogar o configuración familiar nueva): incluya una segunda silueta que represente el futuro —«¿qué querés llevar de este legado a esta nueva etapa?»—. La actividad se vuelve un puente entre el duelo y la reinversión en la vida.

TIPO	Técnica de dramatización y diálogo simbólico
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Duelo con cosas no dichas, relación ambivalente, enojo no expresado, culpa intensa
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Dos sillas, una frente a la otra

Objetivo

Ofrecer al niño un espacio de comunicación simbólica directa con la persona fallecida mediante una técnica adaptada de la silla vacía gestáltica, calibrada para el lenguaje y el desarrollo infantil. Está especialmente indicada cuando hay contenidos no verbalizados que bloquean la elaboración: enojo con el fallecido por haberse ido, pedidos de perdón por peleas antiguas, preguntas sobre la muerte que nadie responde, o simplemente cosas que el niño quería haber dicho. A diferencia de la carta escrita, esta técnica trabaja con la presencia y la espontaneidad, con un impacto afectivo más inmediato y directo. Exige un vínculo terapéutico bien establecido antes de proponerla.

Cómo aplicar

- Preparación del setting (5 min)**
 Ubique dos sillas una frente a la otra. Siéntese al lado del niño, no directamente entre él y la silla vacía. Explique con calma: «Esta silla va a representar a [nombre]. Podés decirle todo lo que quieras: lo que querías decir, preguntar, lo que quedó sin palabras. No tiene que ser lindo. Puede ser cualquier cosa». Si el niño duda, díglele que puede empezar con usted a su lado.
- Inicio del habla (10 a 15 min)**
 Invite al niño a sentarse frente a la silla vacía y a empezar. Si se traba, ofrezca una entrada: «Podés empezar diciendo su nombre, podés decir hola». Muchos niños empiezan con cosas simples y, en medio del habla, acceden a contenidos mucho más densos. Permanezca presente y en silencio, sosteniendo el espacio. Intervenga solo si el niño se angustia mucho sin poder continuar.
- Inversión opcional (10 min)**
 Para niños con buena capacidad de simbolización, a partir de los 8 años, proponga la inversión: «¿Y si te sentás en la silla de [nombre] y me decís lo que te parece que él/ella te respondería?». No es obligatorio y no debe forzarse. Cuando el niño logra hacerlo, el resultado es muy rico: proyecta en la voz del fallecido aquello que él mismo necesita escuchar.
- Procesamiento (10 min)**
 Después de la dramatización, retome la conversación directa: «¿Cómo estás ahora?» y «¿Había algo que no esperabas que saliera?». No interprete de inmediato. Acoja el estado afectivo antes de cualquier elaboración cognitiva.

Lectura clínica

Observe lo que el niño no logra decir. Los silencios largos y las pausas son tan informativos como el contenido hablado. Un niño que se sienta y queda en silencio prolongado está, probablemente, en contacto con algo muy intenso que todavía no tiene forma verbal. No llene ese silencio. Un niño que habla con mucha fluidez pero sin afecto aparente puede estar describiendo sin contacto real con el contenido emocional; desacelere: «Esperá. Acabás de decir algo muy importante. Quedate un poco con eso». La inversión de silla es clínicamente reveladora: lo que el niño pone en boca del fallecido suele ser lo que él más necesita escuchar —perdón, permiso para ser feliz, reconocimiento del amor—. Si el fallecido dice cosas punitivas o críticas, indica que la representación interna del fallecido carga aspectos agresivos que hay que trabajar.

Preguntas orientadoras

- Si pudieras hacerle una pregunta ahora, ¿cuál sería?
- ¿Hay algo que necesitás que él/ella sepa?
- ¿Qué te parece que te diría si pudiera responder?
- ¿Hay algo que quedó entre ustedes dos y que todavía pesa?
- ¿Qué sentiste al decir esto en voz alta?
- ¿Había algo que querías decir hace mucho y nunca pudiste?

Adaptaciones

Para niños de 5 a 7 años: en lugar de la silla vacía, use un muñeco o peluche que represente al fallecido. El objeto concreto reduce la abstracción de la propuesta.

Para niños muy resistentes: no insista con este formato. Proponga que escriban o dibujen lo que dirían. La resistencia al formato oral puede ser una defensa legítima.

Para duelo por suicidio: técnica especialmente potente y delicada. El niño puede expresar enojo intenso, culpa y preguntas sin respuesta sobre el porqué. No intente responder el «porqué»: acoja la pregunta como el dolor que es.

TIPO	Recurso de uso continuo entre sesiones — diario terapéutico
EDAD	7 a 10 años con lectura y escritura establecidas
DEMANDA	Duelo en fase activa, niño que necesita apoyo entre sesiones y un canal de expresión cotidiano
DURACIÓN	Presentación en sesión: 20 min. Uso autónomo entre sesiones.
MATERIALES	Cuaderno pequeño, lapicera o lápices de colores

Objetivo

Crear un canal de expresión emocional estructurado que el niño pueda usar de forma autónoma entre las sesiones, reduciendo el aislamiento del duelo en el cotidiano y ofreciendo al terapeuta material rico para explorar. El diario cumple función de contención: cuando el niño está solo y llega la añoranza, tener un lugar definido para ponerla evita que el afecto desborde sin canal de salida. Para niños en duelo reciente, sobre todo en los primeros meses, la semana entre sesiones puede ser muy larga; el diario acorta ese espacio al crear un ritual diario de cuidado del propio estado emocional. Importante: el diario no es una tarea. Nunca lo reclame ni evalúe su llenado.

Cómo aplicar

1

Sesión de presentación — Creación del diario (20 min)

Presente el cuaderno: «Este diario es solo tuyo. Podés escribir, dibujar, pegar cosas, dejar en blanco los días que no quieras escribir. No hay reglas». Proponga que el niño decore la tapa en la sesión, creando vínculo con el objeto. Muestre tres tipos de página posibles: (1) Página del día: cómo fue el día en relación con el duelo, una palabra, un color, una frase; (2) Página de recuerdo: cuando recuerde algo del fallecido; (3) Página de lo que necesitaba decir: para cuando surja algo que no logra decir en voz alta. Deje que el niño elija qué tipos usar.

2

En las sesiones siguientes (10 a 15 min al inicio)

Empiece cada sesión preguntando: «¿Escribiste en el diario esta semana? ¿Hay algo que quieras mostrarme o contarme?». Si no escribió, acoja sin juzgar. Si escribió y no quiere mostrarlo, respételo. El diario es suyo. Lo que comparte es una elección activa de confianza.

Lectura clínica

La regularidad del llenado es dato clínico. Un niño que llena todos los días busca activamente un canal de expresión. Uno que nunca lo llena puede estar en evitación o simplemente no tener el hábito. Cuando el niño deja de escribir tras un período regular, investigue: puede ser señal de mejoría y menor necesidad del canal, o señal de duelo inhibido o de silenciamiento en el ambiente familiar. Lo que trae del diario a la sesión suele ser lo más activado en la semana, con frecuencia el punto más sensible del proceso. Trate el contenido traído del diario con prioridad.

Preguntas orientadoras

- ¿Escribiste algo esta semana que quieras contarme?
- ¿Hubo algún día más difícil? ¿Qué escribiste ese día?
- ¿Hay alguna página que no quieras mostrarme pero puedas decirme de qué se trata?
- ¿Cómo te sentís después de escribir?
- ¿Hubo algo que quisiste escribir pero no encontraste las palabras?

Adaptaciones

Para niños que todavía no escriben: «diario de dibujos», cada día un dibujo o un círculo con el color que representa cómo se está sintiendo.

Para niños resistentes a cualquier registro: «diario de voz» grabado en el celular de los padres.

Para niños en un ambiente doméstico inseguro: guarde el diario en el consultorio para proteger la privacidad del niño.

TIPO	Construcción de un ritual terapéutico de uso doméstico con orientación a la familia
EDAD	4 a 9 años
DEMANDA	Duelo con síntomas nocturnos: dificultad para dormir, pesadillas, miedo a la oscuridad, hiperapego a la figura cuidadora
DURACIÓN	30 a 40 minutos en sesión para la construcción; práctica diaria en casa
MATERIALES	Papel para dibujar el ritual, objeto de transición elegido por el niño

Objetivo

Construir junto al niño un ritual nocturno personalizado que funcione como ancla de regulación emocional en el momento del día en que el duelo suele ser más intenso. La noche es un período crítico para los niños en duelo: la ausencia de estímulos externos, el silencio y la separación del cuidador para dormir reactivan la experiencia de pérdida de forma aguda. Los niños que perdieron a un progenitor suelen presentar dificultad para dormir, pesadillas recurrentes, rechazo a ir al cuarto solos y conductas regresivas. El ritual nocturno no elimina el sufrimiento, pero ofrece previsibilidad, contención y la sensación de que hay una forma de atravesar el momento difícil. El diferencial clínico es que el ritual lo construye el propio niño en sesión, lo que aumenta mucho la adhesión.

Cómo aplicar

1

Mapeo de las noches (10 min)

Investigue cómo son las noches del niño: «¿Cómo estás durmiendo? ¿Qué pasa cuando te vas a la cama?». Mapee lo difícil: apagar la luz, el silencio, los pensamientos, los sueños. No interprete, solo levante el mapa.

2

Construcción del ritual (15 min)

Proponga: «Vamos a crear juntos un ritual de buenas noches que sea tuyo. Cada paso lo decidís vos». Constrúyalo con 4 o 5 pasos como máximo. Elementos que el niño puede elegir incluir: un momento para recordar al fallecido (mirar una foto, decirle buenas noches en voz alta o mentalmente); un objeto de transición que represente al fallecido (una remera, un juguete que era suyo); una respiración de tres tiempos (inspirar contando hasta 3, soltar contando hasta 3); una frase creada por el niño para repetir antes de dormir; un acuerdo con el progenitor sobreviviente sobre qué pasa si tiene una pesadilla.

3

Registro visual (5 min)

Dibuje el ritual en papel, cada etapa con un símbolo. El niño puede pegarlo en la pared del cuarto como ancla concreta para usar solo a la noche.

4

Orientación al progenitor sobreviviente

Es fundamental que el adulto cuidador conozca el ritual y lo sostenga en casa. La consistencia del ritual es lo que produce la sensación de seguridad. En una sesión de devolución con el familiar, explique su función y la importancia de mantenerlo incluso los días en que el adulto también está en duelo.

Lectura clínica

El objeto de transición elegido revela mucho: los niños que eligen objetos ligados al olor o la textura del fallecido buscan una experiencia sensorial de contacto, una forma primitiva y legítima de mantener la presencia. No lo sustituya prematuramente. Cuando el niño construye un ritual muy largo y rígido, puede indicar ansiedad generalizada usando el ritual como intento de control. Cuando se niega a crear cualquier ritual diciendo que «no sirve de nada», observe otros indicadores de depresión infantil asociada al duelo.

Preguntas orientadoras

- ¿Cómo son tus noches desde que [nombre] se fue?
- ¿Qué te pasa por la cabeza cuando estás en la cama a oscuras?
- ¿Tenés pesadillas? ¿Qué pasa en ellas?
- ¿Hay algo que te haga sentir más seguro a la noche?
- ¿Tenés algún objeto que te recuerde a [nombre] y que te gustaría tener cerca cuando dormís?

Adaptaciones

Para niños con TEPT tras una muerte violenta: el ritual debe incluir técnicas de regulación del sistema nervioso, respiración diafragmática y descenso de la activación fisiológica antes de dormir.

Para niños que compartían el cuarto con el fallecido: incluya en el ritual una forma de reappropriación del espacio físico, como reorganizar algo o crear un rincón especial.

TIPO	Juego estructurado de preguntas y respuestas con tarjetas
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Niño con creencias distorsionadas sobre la muerte, culpa mágica, confusión sobre la reversibilidad
DURACIÓN	35 a 45 minutos
MATERIALES	Tarjetas con afirmaciones: algunas verdaderas, algunas mitos. Preparar antes de la sesión.

Objetivo

Investigar y trabajar las creencias que el niño construyó sobre la muerte: distorsiones generadas por el pensamiento mágico infantil, por información inadecuada de los adultos, o por el intento de protegerlo con eufemismos como «se fue de viaje», «está durmiendo», «se convirtió en una estrellita». El problema de los eufemismos es que generan confusión cognitiva con consecuencias emocionales serias: el niño que cree que el padre «se fue de viaje» queda esperando el regreso; el que cree que «está en el cielo viéndote» puede sentirse vigilado y avergonzado. El formato de juego reduce la amenaza de abordar directamente la muerte y permite que el niño exprese sus creencias sin sentir que lo evalúan o corrigen.

Cómo aplicar

1

Preparación de las tarjetas (antes de la sesión)

Ejemplos de afirmaciones: «Cuando alguien muere, puede volver si rezamos mucho» — MITO. «La muerte es para siempre, la persona no vuelve más» — VERDAD. «Si me porté mal, puedo haber causado la muerte de alguien» — MITO. «Sentir enojo con quien murió es normal y no le hace mal» — VERDAD. «Pensar mucho en quien murió puede enfermarte» — MITO. «La añoranza puede doler mucho, pero no mata» — VERDAD. «Si me olvido de la persona, significa que no la quise lo suficiente» — MITO.

2

Aplicación en sesión (30 min)

Coloque las tarjetas mezcladas sobre la mesa. Proponga: «Voy a dar vuelta una tarjeta por vez. Vos me decís si te parece verdad o mito». No señale antes. Para cada tarjeta: el niño categoriza; usted pregunta «¿por qué te parece eso?»; recién después aborda la respuesta correcta sin tono de corrección, con curiosidad: «Es interesante lo que pensás sobre esto. Yo leí que...». Atención especial a las tarjetas en que el niño se equivoca con convicción.

Lectura clínica

La culpa mágica es el fenómeno más importante a rastrear. Los niños pequeños, hasta los 7 u 8 años, operan a menudo con el pensamiento preoperacional de que sus deseos y acciones tienen poder causal sobre la realidad. Un niño que peleó con el padre la semana en que él murió puede creer genuinamente que causó la muerte. Cuando la tarjeta sobre «portarse mal causa la muerte» se responde con certeza como verdad, deténgase ahí y profundice. La tarjeta sobre olvidar es especialmente importante: «si me olvido, no la quise lo suficiente». Cuando el niño la categoriza como verdad, revela una trampa común del duelo infantil: la creencia de que mantener el duelo activo es una prueba de amor, lo que puede impedir la inversión en nuevas relaciones y nuevas etapas de la vida.

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué te parece que esta es verdad o mito?
- ¿Alguien ya te explicó cómo funciona la muerte?
- ¿Hay algo sobre la muerte de [nombre] que todavía no entendés?
- ¿Alguna vez pensaste que podrías haber hecho algo distinto para evitar que muriera?
- ¿Sentís que se puede recordar a una persona y aun así seguir con la vida?

Adaptaciones

Para niños de 4 a 6 años: use solo 5 o 6 afirmaciones en lenguaje muy concreto.

Para familias con una fuerte creencia religiosa: adapte las tarjetas respetando la cosmología de la familia. Fe y negación son cosas distintas, y el trabajo es diferenciar una de la otra.

Para niños que revelan una culpa mágica intensa durante el juego: detenga el juego ahí y trabaje esa creencia específica en profundidad. El juego sirvió de diagnóstico.

TIPO	Actividad proyectiva de genograma adaptado con dibujo
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo con sentimiento de abandono, miedo a perder a otras personas, reorganización del sentido de pertenencia familiar
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja grande, marcadores de colores, lápices de colores

Objetivo

Trabajar el sentido de pertenencia y la red de apoyo del niño en duelo mediante una representación visual de la estructura familiar que contemple tanto a los que se fueron como a los que permanecen. Tras la muerte de un progenitor, muchos niños desarrollan ansiedad anticipatoria de pérdida: pasan a temer que otros miembros mueran, se apegan mucho al progenitor sobreviviente y se resisten a las separaciones. El árbol de la familia ancla concretamente quién está presente, cuáles son las relaciones de apoyo disponibles y dónde ocupa lugar todavía el fallecido, aunque sea simbólico, en la estructura familiar del niño.

Cómo aplicar

1

Presentación (3 min)

Entregue la hoja grande y diga: «Vamos a dibujar el árbol de tu familia. Cada persona va a ser una parte del árbol: rama, hoja, raíz, tronco, flor. Vos decidís qué es cada uno». No imponga una estructura. Deje que el niño organice como quiera.

2

Construcción del árbol (20 a 25 min)

El niño dibuja libremente. Pregunte por cada elemento: «¿Quién es este? ¿Por qué lo pusiste acá?». Observe quién queda cerca del tronco, quién en los bordes, a quién duda en incluir y, especialmente, dónde coloca al fallecido. Algunos lo ponen como raíz, otros como hoja que cayó, otros como estrella por encima del árbol. Cada representación tiene un significado clínico distinto.

3

La red de apoyo (10 min)

Al final pregunte: «Cuando estás triste o con miedo, ¿a qué parte de este árbol vas?». Esto identifica la figura de apoyo primaria disponible. Pregunte también: «¿Hay alguien en este árbol con quien todavía no podés hablar sobre [nombre]?». Esto mapea los bloqueos de comunicación sobre el duelo dentro de la familia.

Lectura clínica

La posición del fallecido en el árbol es el elemento más rico. Fallecido como raíz: el niño todavía ancla la estructura familiar en la figura perdida, lo que puede indicar dificultad para reconocer los vínculos que permanecen. Fallecido como hoja caída: representación integrada de la pérdida —la hoja fue parte del árbol y siempre lo será, pero cayó—. Fallecido como estrella fuera del árbol: distanciamiento o dificultad para integrar al fallecido a la narrativa familiar actual. Cuando el niño se coloca a sí mismo en una posición muy periférica o muy pequeña en el árbol, puede estar sintiéndose marginado en el sistema familiar, invisible en el duelo de los adultos o inseguro sobre su lugar en la familia reorganizada.

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué elegiste poner a [nombre] en ese lugar del árbol?
- ¿A quién de este árbol buscás más cuando estás triste?
- ¿Hay alguien acá que te gustaría que estuviera más cerca?
- ¿Hay alguien con quien todavía no podés hablar sobre [nombre]?
- ¿Qué cambió en este árbol después de que [nombre] se fue?
- Si el árbol pudiera hablar, ¿qué diría sobre vos?

Adaptaciones

Para niños con familia reconstituida: incluya explícitamente la posibilidad de poner personas que «son familia aunque no sean de sangre». Ampliar el concepto de familia puede ser terapéutico en sí mismo.

Para niños con ansiedad anticipatoria intensa: use el árbol para una conversación directa sobre quién lo cuida y qué pasaría en distintos escenarios. Esto no aumenta el miedo, estructura el pensamiento ansioso.

TIPO	Actividad expresiva con arcilla o masa, recurso somático
EDAD	4 a 9 años
DEMANDA	Duelo somatizado, niño con quejas físicas sin causa orgánica, niño que no accede a las emociones por la vía verbal
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Arcilla o masa casera, superficie limpia

Objetivo

Acceder al contenido emocional del duelo por la vía sensorial y corporal, sorteando la barrera verbal que suele bloquear el proceso terapéutico con niños en duelo. La somatización es una de las formas más comunes de expresión del duelo infantil no elaborado: dolores de panza, de cabeza, cansancio inexplicable, falta de apetito. Al trabajar con arcilla, el niño accede a un canal sensorial y motor que evita las defensas cognitivas y permite que el contenido emocional emerja de forma más directa. El producto final de la escultura no es el objetivo: el proceso de hacerla es el recurso terapéutico.

Cómo aplicar

- 1 Calentamiento sensorial (5 min)**
Entregue la arcilla y deje que el niño explore libremente: amasar, golpear, estirar, enrollar. No proponga nada todavía. Ese contacto sensorial inicial es regulador. Observe la calidad del contacto: un niño que golpea con fuerza puede estar descargando enojo; uno que moldea con cuidado está en un estado más reflexivo.
- 2 La propuesta de modelado (5 min)**
Tras el calentamiento, proponga una de tres consignas según el momento clínico. Opción A, para duelo reciente: «¿Podés modelar lo que sentís cuando pensás en [nombre]? Puede ser una forma, un peso, una textura que represente ese sentimiento». Opción B, para niños con quejas somáticas: «¿Dónde en tu cuerpo sentís ese dolor? ¿Podés modelar cómo es ese dolor por dentro?». Opción C, para la fase de resignificación: «¿Podés modelar algo que represente lo que quedó dentro tuyo de [nombre]?».
- 3 Modelado acompañado (20 min)**
Quédese presente mientras el niño trabaja. Pregunte ocasionalmente sin interrumpir el flujo. Si quiere, modele usted también algo a su lado: eso iguala la relación y reduce la asimetría.
- 4 Narrativa de la escultura (10 min)**
Cuando termine, invite: «Contame qué hiciste». No interprete la escultura por él. Haga preguntas abiertas sobre qué es cada parte, qué quiere decir la escultura, si tiene un nombre, si necesita algo.

Lectura clínica

La calidad del trabajo con la arcilla es una ventana al estado emocional. Arcilla muy amasada o destruida puede representar enojo o impotencia. Arcilla cuidadosamente modelada en formas delicadas indica un intento de control del material emocional. Un niño que modela una figura humana y después la destruye revela algo sobre su proceso de duelo: pregunte «¿Qué le pasó? ¿Cómo te sentiste al destruirla?». Las esculturas que el niño nombra con el nombre del fallecido y guarda con cuidado extremo pueden revelar la necesidad de un objeto transicional concreto. Evalúe con la familia si tiene sentido que el niño la lleve a casa o si permanece en el consultorio.

Preguntas orientadoras

- Contame qué modelaste. ¿Qué es cada parte?
- Si esta escultura pudiera hacer un sonido, ¿cuál sería?
- ¿Hay algún lugar de tu cuerpo donde sentís el duelo más fuerte?
- Si pudieras transformar esta escultura en otra cosa, ¿qué harías?
- ¿Esta escultura necesita algo? ¿Qué te pide?

Adaptaciones

Para niños que rechazan el contacto con la arcilla: reemplácela por harina con agua o por papel amasado. Lo importante es el contacto con un material maleable y la posibilidad de destruir y reconstruir.

Para niños con quejas somáticas frecuentes: pídales que hagan primero un mapa corporal marcando dónde sienten el dolor, y después modelen en arcilla la forma de ese dolor. La doble representación, visual y táctil, es especialmente potente.

TIPO	Creación de una historia terapéutica por el niño — narrativa proyectiva
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo con narrativas de culpa, vergüenza, narrativas familiares silenciosas o distorsionadas sobre la muerte
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hojas en blanco, marcadores, lápices de colores

Objetivo

Acceder y trabajar la narrativa interna que el niño construyó sobre la muerte, porque todo niño construye una historia explicativa sobre lo que pasó, y esa historia rara vez se cuenta en voz alta. Cuando la narrativa interna es distorsionada —como «mi papá murió porque yo era un mal hijo»—, opera silenciosamente como organizadora de la identidad y como obstáculo al proceso de duelo. El recurso propone que el niño cree una historia con personajes ficticios que viven una situación de pérdida. La distancia del personaje permite acceder al contenido sin el peso de la exposición directa. La historia que el niño inventa dice mucho sobre la historia que vive.

Cómo aplicar

1

La invitación (5 min)

Diga: «Vamos a inventar una historia juntos. La historia tiene un personaje —puede ser un animal, un niño, un héroe, lo que quieras— y ese personaje perdió a alguien muy importante para él. A partir de ahí, vos creás cómo sigue la historia». Deje que el niño elija el personaje, el tipo de pérdida y el contexto.

2

Construcción colaborativa (25 min)

El niño crea la historia y usted acompaña con preguntas que profundizan temas clínicamente relevantes. No dirija la trama. Pregunte: «¿Y cómo se sintió el personaje cuando se enteró?», «¿Qué hicieron las otras personas alrededor?», «¿Le contó a alguien lo que estaba sintiendo?», «¿Qué creyó que había hecho mal?», «¿Cómo termina la historia?». Si se traba, proponga un rumbo en forma de pregunta: «¿Qué te parece que podría pasar ahora?».

3

El giro (5 min)

Cuando la historia llegue al punto de mayor dolor, proponga: «¿Qué necesitaría el personaje que pasara ahora para poder atravesar esto?». La respuesta revela lo que el propio niño está necesitando: de quién, de qué forma, con qué calidad de presencia.

4

El puente a la vida real (5 min)

Al final, tienda el puente con cuidado: «Esta historia que inventaste me hizo pensar en vos. ¿Hay algo de lo que le pasó al personaje que se parece a lo que estás viviendo?». El niño puede hacer o no la conexión. Ambas respuestas son válidas.

Lectura clínica

Las historias que inventan los niños tienden a repetir patrones de la propia narrativa interna. Personajes culpables de la pérdida, personajes que concluyen que no son queribles, personajes que quedan solos sin nadie que los ayude: esas tramas señalan las creencias nucleares que el niño carga sobre sí mismo en relación con el duelo. Observe el final de la historia. Finales abruptos sin resolución, o historias que terminan con la muerte del personaje principal, pueden indicar desesperanza. La figura que el niño coloca como apoyo del personaje revela quién siente que podría ser su sostén real. Si el personaje no tiene a nadie, eso es un dato clínico urgente sobre el aislamiento del niño en el duelo.

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué elegiste ese personaje? ¿Tiene algo que te recuerde a alguien?
- ¿Qué cree el personaje que hizo mal?
- ¿Hay alguien en la historia que ayuda al personaje? ¿Quién es?
- ¿Qué necesitaría escuchar el personaje para poder seguir adelante?
- ¿Hay alguna parte de esta historia que se parezca a tu vida?

Adaptaciones

Para niños muy resistentes a la ficción que dicen «no quiero inventar, quiero hablar de verdad»: acéptelo. Ese pedido de autenticidad significa que el niño está listo para acceder al contenido directamente. Cambie a un recurso más directo.

Para niños muy pequeños (4 a 6 años): usted empieza la historia —«había una vez un cachorro de león que perdió a su mamá»— y el niño dicta qué pasa después.

TIPO	Actividad expresiva con collage, papel rasgado y dibujo — foco en enojo y frustración
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo con enojo no expresado: enojo con el fallecido, con el progenitor sobreviviente, con Dios, con la situación
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja grande A3 o papel kraft, revistas viejas para rasgar, marcadores, lápiz rojo y negro, cola

Objetivo

Ofrecer un canal expresivo estructurado para el enojo en el duelo, una de las emociones más silenciadas y menos acogidas del proceso de duelo infantil. El enojo con el muerto se considera socialmente inadmisibles: «no se puede tener enojo con quien murió», «deberías estar extrañándolo, no enojado». Esa interdicción fuerza el enojo hacia adentro, donde se expresa por vías indirectas: comportamiento agresivo, explosiones sin causa aparente, dificultades escolares, somatización. El panel del enojo crea un espacio explícitamente permitido para que ese afecto emerja, sea nombrado y externalizado sin causar daño. El uso de papel rasgado y collage introduce el elemento físico-motor esencial: el enojo es una emoción de alta activación y necesita un canal corporal, no solo verbal.

Cómo aplicar

1

Normalización del enojo (5 min)

Antes de proponer cualquier actividad, tenga una conversación directa: «Cuando perdemos a alguien, la gente habla mucho de la tristeza y la añoranza. Pero casi nadie dice que también da enojo. Enojo con quien se fue. Enojo con Dios. Enojo con quien quedó. Enojo con toda la situación. Eso es muy normal. Hoy vamos a crear un lugar para que ese enojo salga». Observe la reacción: si el niño se afloja, el enojo estaba represado.

2

Creación del panel (20 a 25 min)

Ponga a disposición todos los materiales. Diga: «Este panel es el lugar del enojo. Podés rasgar, pegar, escribir, tachar, arrugar. No hay nada que no puedas poner acá». Si duda al principio, demuéstrela usted: rasgue un pedazo de revista, péguelo, garabatee con fuerza. El modelado del terapeuta rompe la inhibición. Permanezca presente sin interpretar en voz alta.

3

Nombramiento del enojo (10 min)

Cuando el panel esté listo, pregunte: «¿Qué hay acá? Contame». Pregunte: «¿Para quién es este enojo?» y «¿Qué está diciendo este enojo?».

4

Qué hacer con el enojo (5 min)

Pregunte qué quiere hacer el niño con el panel: guardarlo, destruirlo, llevarlo a casa. No proponga destruirlo si el niño no lo propuso. Algunos construyen y después quieren rasgar todo, lo cual es catártico y puede permitirse con conciencia.

Lectura clínica

La intensidad física con que el niño trabaja el panel es el primer dato clínico. Un niño que rasga papel con fuerza está descargando enojo acumulado: es el proceso terapéutico ocurriendo en tiempo real. Un niño que trabaja con exceso de cuidado en el «panel del enojo» puede estar aún inhibido; normalícelo: «Puede ser más bravo que esto». Observe hacia quién se dirige el enojo. El enojo con el fallecido por haber muerto es sano y frecuente. El enojo con el progenitor sobreviviente puede revelar que el adulto no está lo suficientemente presente en lo emocional. El enojo con Dios o con la vida es un enojo existencial, profundo, legítimo, que debe acogerse sin intento de resolución inmediata. Cuando el enojo se dirige hacia el propio niño —culpa disfrazada de enojo—, hay que identificarlo y trabajarlo directamente.

Preguntas orientadoras

- ¿Para quién es este enojo?
- ¿Qué quiere decir tu enojo? ¿Qué está pidiendo?
- ¿Sabías que se puede tener enojo con alguien que querés al mismo tiempo?
- Cuando sentís ese enojo, ¿qué solés hacer con él?
- ¿Hay algún enojo que todavía no pusiste en el panel y que está guardado?
- ¿Qué pasa cuando dejás salir el enojo?

Adaptaciones

Para niños con comportamiento agresivo explícito: el panel está especialmente indicado, pero debe acompañarse de una conversación sobre canales seguros. «El enojo puede salir acá, en el papel. Lo que no puede es salir pegándole a las personas».

Para niños que niegan cualquier enojo y se muestran excesivamente «buenitos»: proponga que el panel sea «de cualquier sentimiento», no específicamente del enojo. El enojo puede emerger en el proceso sin ser nombrado de antemano.

Para duelo por suicidio: el enojo tiende a ser especialmente intenso y silenciado por culpa y vergüenza social. El panel puede ser el primer espacio en que ese enojo recibe permiso.

TIPO	Protocolo de orientación parental — sesión con el responsable
EDAD	Padres y responsables de niños de 4 a 10 años
DEMANDA	Complemento del trabajo con el niño siempre que el ambiente familiar se identifique como factor de riesgo o de apoyo insuficiente
DURACIÓN	50 a 60 minutos — sesión exclusiva con el adulto, sin el niño
MATERIALES	Ninguno específico. Eventualmente un guion impreso de orientaciones para llevar a casa.

Objetivo

El duelo del niño no ocurre en el vacío: está profundamente modulado por cómo el ambiente familiar maneja la pérdida. El progenitor sobreviviente es, a la vez, la figura de apoyo más importante para el niño y, por lo general, la persona más destrozada por el mismo evento. Esa asimetría —el adulto que más puede ayudar es el que más necesita ayuda— es una de las grandes complejidades del duelo parental infantil. Este recurso ofrece un protocolo de orientación para sesiones con el adulto cuidador, enfocado en traducir a lenguaje cotidiano qué necesita el niño, qué está presentando y cómo el adulto puede ser presencia de apoyo aun estando él mismo en duelo. Importante: esta sesión no es terapia para el adulto, es orientación clínica. Si el adulto necesita apoyo psicológico, déVELO a atención individual propia.

Cómo aplicar

1

Bloque 1 — Cómo está el niño: traducción clínica (15 min)

Comparta, con cuidado y con la autorización implícita o explícita del niño, cómo está llegando a las sesiones, sin revelar contenidos que él pidió mantener en secreto. Use el lenguaje del desarrollo. Traducciones útiles para el adulto: regresión conductual (hacerse pis en la cama, lenguaje infantilizado); búsqueda de seguridad y de ser cuidado; agresividad: enojo que no tiene un canal de salida adecuado; «estoy bien» sin ninguna expresión de tristeza: duelo inhibido por un mensaje implícito de que no es seguro sufrir; quejas físicas sin causa orgánica: somatización del duelo; hiperapego al progenitor sobreviviente: ansiedad anticipatoria de una nueva pérdida.

2

Bloque 2 — Qué necesita el niño del adulto: orientaciones concretas (20 min)

Ejemplos de orientaciones específicas y prácticas: «Cuando venga con una pregunta sobre la muerte, no cambie de tema. Responda con honestidad y lenguaje simple, aunque sea difícil». «Mantenga la rutina lo más posible. Escuela, hora de dormir, cenar juntos: la previsibilidad es un ancla de seguridad». «Permita que lo vea triste. Cuando el adulto esconde todo, el niño aprende que el duelo también debe esconderse». «No use el nombre del fallecido como amenaza ni comparación: eso carga una culpa innecesaria». «Permita que diga el nombre del fallecido, cuente historias, mire fotos. Eso es elaboración, no negación».

Bloque 3 — Qué necesita el adulto: escucha y derivación (15 min)

Reserve un espacio para escuchar brevemente cómo está el adulto. Si identifica un sufrimiento intenso sin apoyo, haga la derivación a atención individual. Sea directo y sin culpabilizar: «Vos también estás pasando por algo muy difícil. Merecés tener a alguien que te cuide a vos también, no solo ser el apoyo de todos».

Lectura clínica

Observe la capacidad de mentalización del adulto respecto del niño: si logra pensar sobre lo que él está sintiendo, o si está tan inmerso en su propio duelo que perdió temporalmente el acceso a la perspectiva del niño. Cuando la mentalización está comprometida, el adulto tiende a interpretar el comportamiento difícil del niño como «berrinche» o «maldad», lo que aumenta el aislamiento del niño en el duelo. Observe cómo habla el adulto del fallecido: adultos que no logran mencionar el nombre, que cambian de tema, o que idealizan al muerto de un modo que no permite ninguna ambivalencia, están transmitiendo mensajes implícitos muy poderosos sobre cómo debe vivirse el duelo.

Preguntas orientadoras para el adulto

- ¿Cómo están pudiendo hablar de [nombre] en casa?
- ¿El niño hace preguntas sobre la muerte? ¿Qué le responden?
- ¿Logran darse cuenta de cuándo está triste, o generalmente dice que está bien?
- ¿Hay algo que el niño hace que no saben cómo manejar?
- ¿Tienen algún apoyo para ustedes mismos en este momento?

Adaptaciones

Para familias en las que el duelo está siendo silenciado activamente: el trabajo con el adulto es tan urgente como el trabajo con el niño. Considere sesiones de orientación más frecuentes antes de que el silencio se consolide como patrón.

Para situaciones en que el progenitor sobreviviente está en duelo complicado: sea directivo en la derivación. El adulto no necesita estar curado para ayudar al niño, pero necesita tener su propio apoyo para que el cuidado no quede completamente solitario.

TIPO	Ritual de cierre terapéutico — actividad de síntesis y celebración del proceso
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Fase final del acompañamiento, cuando hay indicadores de elaboración y el alta se aproxima
DURACIÓN	50 a 60 minutos
MATERIALES	Todos los materiales producidos a lo largo del acompañamiento, hoja nueva, marcadores

Objetivo

Crear un ritual de cierre del proceso terapéutico que sea a la vez una síntesis del camino recorrido y una celebración de la elaboración conquistada. El cierre de un acompañamiento de duelo es, en sí mismo, una experiencia de pérdida: el niño pierde la relación terapéutica, el espacio seguro, el ritual semanal que organizó el duelo. Cuando no hay ritual de cierre, el alta puede reactivar la experiencia de abandono que es central al duelo. Este recurso transforma el cierre en un acto de integración: el niño mira todo lo que produjo a lo largo del proceso, nombra lo que cambió y se va llevando consigo una síntesis de lo que aprendió. Debe proponerse solo cuando hay indicadores clínicos reales de elaboración, no por presión de plazo. Indicadores de que el proceso está listo para cerrar: el niño logra hablar del fallecido con afecto y sin desorganizarse; retomó la inversión en el juego, las amistades y la escuela; los síntomas iniciales remitieron; muestra una comprensión integrada de la permanencia de la muerte.

Cómo aplicar

1

Preparación y anticipación (en la sesión previa al cierre)

Anuncie el cierre con al menos dos sesiones de anticipación: «Estamos llegando cerca del final de nuestro trabajo juntos. En dos semanas va a ser nuestra última sesión por ahora». Esto le da tiempo al niño para procesar la noticia y traer lo que surja.

2

Revisión del recorrido (20 min)

En la sesión final, organice sobre la mesa todo lo producido durante el acompañamiento: la caja de recuerdos, el mapa de la añoranza, las cartas, el diario, el libro del fallecido, el termómetro completado, los paneles, las esculturas. Para cada material pregunte: «¿Qué te acordás de cuando hicimos esto?» y «¿Qué significa este material para vos ahora?». Deje que el niño lidere el ritmo de la revisión.

3

La hoja de lo que aprendí (15 min)

Proponga una hoja nueva: «¿Qué aprendiste sobre vos mismo en este tiempo que estuvimos acá juntos?». No dirija. El contenido de esta hoja suele ser sorprendente: los niños nombran aprendizajes que el terapeuta no anticipó.

Ritual de despedida (10 min)

Proponga un gesto simbólico de cierre que tenga significado para el niño: un apretón de manos especial, una última entrada en el diario, una frase que cada uno le dice al otro. Deje que el niño elija el gesto. Al final, diga directamente: «Fue un honor acompañarte en este camino». Aclare que la puerta no se cierra: «Si en algún momento querés volver, podés». Esto es especialmente importante para niños en duelo que ya vivieron una pérdida irreversible.

Lectura clínica

Observe la reacción del niño al anuncio del cierre en la sesión previa. Un niño que se pone ansioso o regresa levemente no está manipulando: está mostrando que la relación terapéutica tiene importancia y que la separación activa, legítimamente, la experiencia de pérdida. Eso merece elaboración en las sesiones de cierre. Lo que el niño elige llevar a casa es clínicamente significativo: el que se lleva la caja de recuerdos y el libro del fallecido está integrando el duelo en su narrativa de vida. La hoja de «lo que aprendí» puede guardarla el terapeuta como registro del cierre; si el niño regresa en el futuro, cuando el duelo se reactive en otra fase del desarrollo, ese documento es un punto de retomada del recorrido.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué cambió en vos desde que empezamos a trabajar juntos?
- ¿Hay algún momento de nuestras sesiones que nunca vayas a olvidar?
- ¿Cómo estás ahora en relación con [nombre]? ¿Qué es distinto del comienzo?
- ¿Qué vas a hacer cuando sientas la añoranza ahora, sin la sesión?
- ¿Hay algo que todavía te hubiera gustado trabajar y no trabajamos?
- ¿Qué te gustaría decirme antes de despedirnos?

Adaptaciones

Para niños que hicieron pocos materiales a lo largo del proceso (proceso muy verbal, sin registros): reemplace la revisión de materiales por una conversación guiada sobre las sesiones más marcantes.

Para niños cuyo duelo probablemente se reactive en fases futuras (adolescencia, casamiento, nacimiento de hijos): nómbrelo explícitamente. «Es normal que el duelo vuelva en momentos importantes de tu vida. Cuando eso pase, significa que estás creciendo. Y ya tenés herramientas para atravesarlo».

Para procesos interrumpidos por cambio de terapeuta o factores externos: nómbrelo directamente. «No terminamos porque estaba todo listo. Paramos acá por ahora, y eso también es difícil».

TIPO	Psicoeducación y planificación anticipada de fechas de riesgo emocional
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo en cualquier fase — niño que se desmorona en cumpleaños, fechas y feriados sin comprender por qué se pone tan mal en esos momentos específicos
DURACIÓN	40 a 50 minutos — construcción en sesión; uso longitudinal
MATERIALES	Calendario anual impreso o dibujado, marcadores de colores, stickers opcionales

Objetivo

Anticipar y preparar emocionalmente al niño para las fechas de mayor riesgo de intensificación del duelo a lo largo del año, transformando la sorpresa y el desamparo del «¿por qué me puse tan mal hoy?» en reconocimiento y preparación. Fechas como el cumpleaños del fallecido, el Día de la Madre o del Padre, la Navidad, el aniversario de la muerte y el propio cumpleaños del niño concentran una carga simbólica intensa que reactiva el duelo de forma aguda, aun cuando el niño parecía estar bien los días previos. Este fenómeno, descrito como «reacción de aniversario», no es regresión: es una activación esperable del proceso de duelo ante estímulos temporales cargados de significado relacional. Anticipar esas fechas en sesión tiene tres funciones: normalizar la intensificación antes de que ocurra, crear un plan de cuidado específico para cada fecha, y devolverle al niño la sensación de control sobre algo que suele tomarlo por sorpresa.

Cómo aplicar

1

Psicoeducación sobre las fechas difíciles (5 min)

Explique: «¿Te diste cuenta de que en algunas épocas del año se pone más difícil? Como el cumpleaños de él, la Navidad, el Día del Padre. Eso pasa porque nuestro corazón tiene memoria. Cuando llega una fecha que vivíamos con esa persona, el corazón se acuerda y lo siente de nuevo. No es que empeoraste: es que el calendario tiene lugares donde la añoranza se junta».

2

Marcar las fechas del año (15 min)

Recorran el calendario e identifiquen juntos las fechas de riesgo: cumpleaños del fallecido, aniversario de la muerte, fechas familiares, feriados, y fechas de significado personal (el día en que iban al cine juntos, el campeonato que nunca se perdía, el día del inicio de la enfermedad). Marque cada fecha con un color según la intensidad esperada: amarillo para las difíciles, rojo para las muy difíciles.

3

El plan de cuidado por fecha (15 min)

Para cada fecha en rojo, construyan un mini-plan: «¿Qué vas a hacer ese día? ¿Con quién? ¿Qué puede ayudar?». El plan no busca eliminar el dolor, sino crear contención. Elementos posibles: un ritual de recuerdo (encender una vela, mirar fotos, comer algo que le gustaba al fallecido), una persona de apoyo acordada para el día, un permiso explícito para llorar o para no querer hacer nada. Diga: «No tenés que fingir que es un día normal. Y tampoco tenés que quedarte solo con esto».

Integración al proceso terapéutico (5 min)

Mantenga el calendario en el consultorio. En las sesiones cercanas a fechas marcadas, anticipe: «En dos semanas es Navidad. ¿Cómo estás pensando ese día?». Después de la fecha, procese: «¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué ayudó?». Ese ciclo anticipación-vivencia-procesamiento es la columna vertebral del trabajo con fechas de riesgo.

Lectura clínica

Observe qué fechas identifica el niño de forma espontánea versus cuáles necesita sugerir. Las que nombra de inmediato son las que ya está anticipando con ansiedad: ese dato informa la urgencia de la planificación. Fechas que no identifica pero que son objetivamente cargadas (aniversario de la muerte, Día del Padre) pueden estar siendo evitadas defensivamente o genuinamente no pesarle: pregunte directamente antes de suponer. Un niño que no logra identificar ninguna fecha difícil puede estar en duelo inhibido o en fase de negación; en esos casos, el calendario funciona como instrumento diagnóstico antes que de planificación. Observe también la reacción emocional al marcar cada fecha: la intensidad del afecto anticipado ya es dato clínico rico.

Preguntas orientadoras

- ¿Cuál es el día del año que más miedo te da que llegue?
- ¿Cómo fue la última vez que llegó una fecha difícil? ¿Qué hiciste?
- ¿Qué te parece que vas a sentir este Día del Padre?
- ¿Hay alguna fecha que te parece que va a ser más difícil de lo que la gente alrededor espera?
- ¿Qué te ayudaría a atravesar el día más difícil del año?

Adaptaciones

Para duelo reciente (menos de 6 meses): no haga el calendario del año entero; enfóquese solo en los dos o tres meses siguientes. La visión del año completo puede ser abrumadora cuando el duelo aún está muy agudo.

Para familias con creencias religiosas que convierten las fechas en rituales: integre los rituales religiosos ya existentes al plan de cuidado en lugar de crear rituales paralelos. La religiosidad puede ser un recurso poderoso de contención.

Para niños cuyo cumpleaños coincide con un período cercano a la muerte o al cumpleaños del fallecido: trabaje explícitamente la posibilidad de sentir cosas contradictorias en el propio cumpleaños —la alegría y la tristeza pueden coexistir el mismo día—.

TIPO	Intervención familiar con hermanos — sesión conjunta de elaboración del duelo compartido
EDAD	4 a 10 años — sesión con dos o más hermanos
DEMANDA	Duelo vivido de forma aislada por cada hermano, con dificultad de comunicación sobre la pérdida dentro de la fratría
DURACIÓN	50 a 60 minutos — sesión conjunta con los hermanos, sin el progenitor
MATERIALES	Hoja grande A3, marcadores de colores, cartas con emociones

Objetivo

Crear un espacio de comunicación sobre el duelo dentro de la fratría, entre hermanos que suelen vivir la misma pérdida de formas muy distintas y rara vez hablan de ello entre sí. La muerte de un progenitor afecta a cada hermano de forma única según la edad, el vínculo con el fallecido, el lugar en la familia y la personalidad. El mayor puede estar en modo de cuidado de los menores, suprimiendo su propio duelo; el del medio puede sentir que su duelo no lo ve nadie; el menor puede no comprender del todo lo que pasó y ser interpretado como indiferente. Esa asimetría suele generar malentendidos, distancia y aislamiento — cada uno en duelo, pero cada uno solo—. La sesión conjunta usa la perspectiva de Bowlby sobre la importancia del apoyo de las figuras de vínculo: los hermanos son vínculos primarios que pueden ser recursos de apoyo mutuo poderosos si el duelo puede compartirse.

Cómo aplicar

1

Presentación de la propuesta (5 min)

Explique a los hermanos juntos: «Perdieron a la misma persona, pero cada uno la siente de un modo distinto. Eso es normal, cada relación es única. Hoy quiero que descubramos juntos qué siente cada uno, porque a veces creemos que estamos solos en lo que sentimos y después descubrimos que el hermano siente cosas parecidas. O distintas, y también está bien». Establezca la regla de oro: nadie puede decirle al otro que lo que siente está mal.

2

El mapa del duelo de cada uno (20 min)

Divida la hoja grande en tantas partes como hermanos haya. Cada uno tiene su espacio. Pida que cada uno escriba o dibuje: algo que extraña, algo que todavía le cuesta, y algo que descubrió sobre sí mismo desde la pérdida. Trabajan a la vez, cada uno en su espacio. Usted circula y acompaña sin dirigir. Al final, cada uno presenta lo que hizo a los hermanos.

3

Qué es igual y qué es distinto (15 min)

Miren los mapas juntos. Pregunte: «¿Qué notan que es igual en el duelo de cada uno? ¿Y qué es distinto?». Facilite el intercambio sin forzar la convergencia. A veces el descubrimiento más importante es que el hermano que parecía indiferente también extraña, solo que lo expresa de otra forma. Nómbrelo: «¿Los dos están sintiendo la añoranza del mismo modo, o de modos distintos?». Deje que los hermanos se sorprendan unos con otros.

El acuerdo entre hermanos (10 min)

Proponga que los hermanos acuerden algo que van a hacer juntos cuando llegue la añoranza —un ritual de la fratría—. Puede ser simple: mirar fotos juntos los viernes a la noche, contar una historia del fallecido antes de dormir, hacer su comida favorita una vez por semana. El acto de acordar crea responsabilidad mutua y pertenencia al duelo compartido.

Lectura clínica

Observe la dinámica de poder entre los hermanos durante la sesión: quién habla más, quién calla, quién cuida al otro en lugar de cuidarse a sí mismo. El hermano mayor que asume el rol de cuidador y no logra mostrar su propio duelo frente a los menores necesita espacio individual además de la sesión conjunta: el rol de cuidador puede estar silenciando su propio duelo. Observe también al hermano que ríe o minimiza el duelo de los otros: puede estar usando el humor como defensa o estar genuinamente en otra fase del proceso. No confronte: registre y trabájelo individualmente. La sesión conjunta no reemplaza las sesiones individuales: es un complemento que abre un canal que las individuales no logran abrir.

Preguntas orientadoras

- ¿Sabías que tu hermano sentía esto? ¿Te sorprendió?
- ¿Hay algo que nunca le habías contado a tu hermano sobre cómo te estás sintiendo?
- ¿Te parece que tu hermano entiende lo que estás pasando? ¿Por qué?
- Cuando estás con mucha añoranza, ¿buscás a tu hermano o preferís estar solo?
- ¿Hay algo que te gustaría pedirle a tu hermano que te ayudaría en este momento?

Adaptaciones

Para hermanos con gran diferencia de edad (más de 4 años): adapte la actividad de mapeo a la edad de cada uno —el menor puede dibujar mientras el mayor escribe—. La riqueza está en la presentación mutua, no en la uniformidad del formato.

Para situaciones en que los hermanos tienen un conflicto activo ligado al duelo (disputas por pertenencias del fallecido, peleas sobre quién lo quería más): no haga la sesión conjunta todavía. Trabaje individualmente hasta que haya suficiente seguridad para el encuentro.

Para un hermano que perdió a otro hermano (no al progenitor): adapte el encuadre —la pérdida de un hermano tiene dinámicas específicas de culpa del sobreviviente y de cambio de lugar en la familia—.

TIPO	Técnica proyectiva para acceder a contenidos silenciados por protección al adulto en duelo
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo con silenciamiento autoimpuesto — niño que esconde su sufrimiento para no aumentar el dolor del progenitor sobreviviente, que dice «estoy bien» para proteger al adulto
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Cajita pequeña o sobre, papelitos doblados, lapicera

Objetivo

Acceder y dar voz al duelo silenciado que el niño carga exclusivamente para sí por un mecanismo de protección al adulto en duelo, uno de los fenómenos más significativos y menos visibles del duelo infantil. Los niños en duelo suelen desarrollar, de forma espontánea y temprana, una sensibilidad aguda al sufrimiento del progenitor sobreviviente. Perciben cuándo el adulto está al límite. Aprenden a suprimir sus propias expresiones de duelo para no sobrecargar a quien ya está sobrecargado. El resultado es un niño que parece «demasiado bien» —que no llora, no pregunta, no demuestra— mientras por dentro acumula un duelo sin canal de salida. Ese silenciamiento autoimpuesto, descrito como «duelo parentificado», no es sano: aumenta el aislamiento, impide la elaboración y suele manifestarse por vías somáticas o conductuales. El cofre de los secretos crea un espacio explícitamente separado del adulto —solo del niño y de la psicóloga— donde lo que fue silenciado puede finalmente tener lugar.

Cómo aplicar

1

Nombrar el silencio (10 min)

Empiece con una conversación directa pero cuidadosa: «Me di cuenta de que a veces decís que estás bien aunque yo creo que puede estar difícil. Te quiero preguntar algo y podés responder con honestidad: ¿hay algo que sentís sobre la pérdida de [nombre] que no le contás a tu mamá/papá para no ponerlo más triste?». Si el niño duda, normalícelo: «Es muy común. Muchos niños lo hacen. No está mal, es cuidado. Pero acá este espacio es solo tuyo. No tenés que cuidar a nadie acá».

2

Construcción del cofre (5 min)

Presente la cajita: «Este es el cofre de los secretos. Todo lo que escribas o dibujes y pongas acá dentro es solo tuyo, y mío como tu psicóloga. No llega a los adultos de tu vida. Acá podés poner todo lo que fuiste guardando».

3

Llenado de los papelitos (20 min)

Ofrezca papeles pequeños y proponga que el niño escriba o dibuje —uno por papel— las cosas que guardó. Aperturas si se traba: «¿Qué sentís cuando ves a tu mamá triste y no decís nada?», «¿Hay alguna pregunta sobre [nombre] que no hiciste para no poner más triste al adulto?», «¿Hay algo que sentís que te parece que no deberías sentir?». No fuerce el llenado: incluso un papel en blanco doblado y puesto en el cofre tiene significado clínico.

Procesamiento de lo guardado (10 min)

Si el niño quiere, abran algunos papeles juntos y trabajen el contenido. Si no quiere abrir nada todavía, respételo: el cofre puede revisitarse en sesiones futuras. Lo importante es nombrar lo que pasó: «Acabás de poner en un lugar seguro cosas que te venían pesando en soledad. Eso es un paso importante».

Lectura clínica

La cantidad y el contenido de lo que el niño pone en el cofre son datos clínicos primarios. Un cofre vacío tras una invitación genuina puede indicar duelo genuinamente inhibido, dificultad de acceso al propio contenido emocional, o una relación terapéutica todavía no lo bastante segura para revelar los secretos. Un cofre muy lleno, llenado con intensidad, indica que había un acúmulo significativo de contenido silenciado a la espera de espacio. Observe especialmente el tema de lo guardado: las preguntas no hechas sobre las circunstancias de la muerte son frecuentes y necesitan respuesta cuidadosa en las sesiones siguientes. El enojo con el progenitor sobreviviente guardado en el cofre por miedo a lastimarlo es un contenido clínicamente urgente: el niño que no puede enojarse con quien más necesita está en un nivel de autocontención que merece atención inmediata.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay algo que sientas sobre [nombre] que nunca le contaste a nadie?
- Cuando estás triste y ves que el adulto alrededor también lo está, ¿qué hacés?
- ¿Alguna vez dejaste de hacer una pregunta sobre [nombre] para no poner a alguien más triste?
- ¿Cómo te sentís cuando guardás cosas para no herir a las personas?
- Si supieras que podés decir todo sin herir a nadie, ¿qué dirías?

Adaptaciones

Para niños con un progenitor sobreviviente muy frágil: el cofre no reemplaza el trabajo con el adulto. En paralelo, trabaje con él la capacidad de sostener el duelo del niño sin sobrecargarlo con el propio —use el recurso 19 (Conversaciones con Quien Quedó) en conjunto—.

Para niños que revelan en el cofre situaciones de sobrecarga extrema (cuidar a los hermanos menores, manejar solos las crisis del progenitor): evalúe la necesidad de una conversación más directa con la familia sobre la distribución de responsabilidades.

TIPO	Técnica cognitiva de distinción entre información real y construcción imaginaria sobre la muerte
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo con fantasías elaboradas sobre las circunstancias de la muerte — niño que llena los vacíos de información con la imaginación, a menudo de forma más aterradora que la realidad
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja dividida en dos columnas: «Lo que sé» y «Lo que imagino», lapicera

Objetivo

Ayudar al niño a distinguir entre lo que sabe de hecho sobre la muerte y las circunstancias de la pérdida — información recibida de adultos confiables— y lo que construyó con su propia imaginación para llenar los vacíos de lo no dicho. Los niños tienen una capacidad extraordinaria de construir narrativas explicativas para lo inexplicable, y cuando los adultos evitan hablar de la muerte para «proteger», el vacío de información se llena con la fantasía, que a menudo es más aterradora, más culposa y más distorsionada que la realidad. El niño que no sabe cómo murió el padre puede imaginar que fue algo horrible que él podría haber impedido; el que no vio el cuerpo puede imaginar que el fallecido sufre en algún lugar. Este recurso, fundamentado en el principio de Worden de que el niño tiene derecho a información honesta y adaptada a su capacidad de comprensión, crea un espacio seguro para que esas fantasías salgan y puedan trabajarse con honestidad.

Cómo aplicar

1

Presentación de la distinción (5 min)

Explique: «Cuando no sabemos todo sobre lo que pasó, nuestra cabeza inventa. Es automático, no es tu culpa. A veces lo que inventamos es hasta más aterrador que lo que realmente pasó. Hoy vamos a separar lo que sabes de verdad de lo que imaginaste. No es una prueba: es para que sepas qué es real y qué creó tu cabeza para tratar de entender».

2

Llenado de las dos columnas (20 min)

Con la hoja dividida en dos columnas, pida que el niño vaya poniendo en la columna que corresponda lo que sabe y lo que imagina sobre: cómo murió el fallecido, qué pasó en el momento de la muerte, cómo fue después, dónde está el fallecido ahora, por qué pasó. Para cada ítem de «Lo que imagino», pregunte con curiosidad genuina: «¿Esta es una idea que se te ocurrió? ¿De dónde vino? ¿Alguien te lo dijo o lo pensaste solo?». No contradiga todavía: mapee primero.

3

Trabajar las fantasías (15 min)

Con la columna de fantasías mapeada, aborde cada una con cuidado. Las que pueden corregirse con información real (cómo murió el padre, qué hace el hospital): corrija con honestidad y lenguaje accesible, después de acordar con la familia qué puede decirse. Las que no tienen respuesta real disponible (dónde está el fallecido, si está bien): trabaje la tolerancia a la incertidumbre sin imponer una respuesta. Las de culpa mágica: trabájelas en profundidad con el protocolo del recurso 14 (El Juego de la Verdad sobre la Muerte).

El derecho a saber (5 min)

Cierre con una frase directa: «Tenés derecho a saber sobre lo que pasó en tu familia, en tu lenguaje. Si hay alguna pregunta que todavía no hiciste y querés hacer, yo puedo ayudarte a encontrar a quién puede responderla». Identifique qué preguntas de la columna de fantasías necesitan una conversación con el progenitor sobreviviente y planifique cómo facilitarla.

Lectura clínica

El contenido de la columna «Lo que imagino» es el material clínico más rico de este recurso. Fantasías muy elaboradas y coherentes indican que el niño pensó mucho en esto a solas: hay una rumiación activa en torno a las circunstancias de la muerte que no se está procesando en voz alta. Las fantasías de culpa («imagino que murió porque hice algo mal») necesitan intervención directa y prioritaria. Las fantasías sobre el estado actual del fallecido («imagino que tiene frío», «que me ve sufrir y está triste») revelan mucho sobre el modelo interno de relación con el muerto que el niño construyó, y ese modelo debe trabajarse con cuidado, respetando la creencia religiosa de la familia sin reforzar fantasías que generen sufrimiento adicional.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay algo sobre cómo murió [nombre] que no sabés y te quedás pensando?
- ¿Qué imaginás que pasó en el momento en que murió?
- ¿Pensás en dónde está ahora? ¿Qué te imaginás?
- ¿Hay alguna idea en tu cabeza sobre por qué pasó que te asuste?
- Si pudieras hacerle una pregunta a alguien que sabe todo lo que pasó, ¿cuál sería?

Adaptaciones

Para muertes en circunstancias que la familia decidió no revelar por completo (suicidio no revelado, muerte violenta con detalles ocultos): esta actividad requiere alineamiento previo con la familia sobre lo que puede decirse. No revele información sin acuerdo con los responsables. Si la familia optó por ocultar, trabaje la tolerancia a la incertidumbre en lugar de revelar lo que se decidió mantener privado.

Para niños con fantasías muy aterradoras sobre el estado actual del fallecido: evalúe si hay síntomas de TEPT asociados —imágenes intrusivas y fantasías persistentes sobre las circunstancias de la muerte pueden indicar necesidad de un protocolo específico de trauma—.

TIPO	Técnica de conciencia corporal aplicada al duelo — rastreo de las sensaciones físicas
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo somatizado o con poco acceso verbal a las emociones — niño con quejas físicas recurrentes sin causa orgánica, o que no logra nombrar lo que siente pero lo manifiesta corporalmente
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Silueta corporal grande (A3), marcadores de colores, lápices de colores

Objetivo

Mapear las sensaciones físicas del duelo en el cuerpo del niño como forma de acceder al contenido emocional por la vía somática, especialmente indicado para niños que no tienen acceso verbal a sus emociones o que expresan el duelo predominantemente por el cuerpo. La investigación en neurociencia afectiva —en particular los estudios de mapeo corporal de emociones de Nummenmaa y colaboradores— muestra que distintas emociones activan patrones consistentes de sensaciones físicas. El duelo tiene una firma somática reconocible: peso en el pecho, nudo en la garganta, vacío en el estómago, cansancio en las piernas. Para niños que responden «no sé» a las preguntas emocionales directas pero llegan a la sesión con dolor de panza, de cabeza o fatiga inexplicable, el cuerpo comunica lo que las palabras todavía no alcanzan. El mapeo somático no solo accede a ese contenido: también valida la experiencia física del duelo, a menudo invalidada por los adultos con «no es nada», «ya se va a pasar», «estás bien».

Cómo aplicar

1

El cuerpo como mensajero (5 min)

Explique: «¿Sabías que el cuerpo siente las emociones? No solo la cabeza, el cuerpo entero. Cuando tenemos miedo, el corazón late más rápido. Cuando tenemos enojo, la cara se pone caliente. Cuando tenemos añoranza... ¿qué pasa en tu cuerpo?». Deje que el niño intente responder. Si no sabe, proponga: «Hoy lo vamos a descubrir juntos».

2

Mapeo de la añoranza en el cuerpo (20 min)

Entregue la silueta. Pida que el niño cierre los ojos un momento y piense en [nombre] —en un recuerdo específico, en un momento de añoranza—. Después: «Ahora abrí los ojos. ¿Dónde sentiste algo en el cuerpo mientras pensabas en él? Puede ser leve, pesado, un hormigueo». El niño marca en la silueta con colores: elige un color por tipo de sensación. Pida que nombre cada región: «¿Qué es esto de acá?».

3

Mapeo de otras emociones del duelo (10 min)

Repita con otras emociones del duelo: enojo, miedo, alivio, amor. Para cada una, el niño piensa en la emoción, escanea el cuerpo y marca con un color distinto. Al final, la silueta tendrá un mapa de colores de las emociones en el cuerpo. Pregunte: «Mirando esta silueta, ¿qué ves?». Observe las superposiciones: las regiones donde se concentran varias emociones son los puntos de mayor tensión somática.

Qué hacer con lo que el cuerpo siente (5 min)

Para las regiones de mayor concentración emocional, proponga una práctica breve de atención: «Poné la mano acá. Respirá. ¿Qué necesita este lugar?». Esa pregunta suele abrir contenido emocional que las preguntas directas no acceden. No fuerce la respuesta: el contacto físico con el propio cuerpo ya es la intervención.

Lectura clínica

El patrón de distribución de las sensaciones en la silueta es clínicamente informativo. La concentración intensa en el pecho y la garganta es el patrón más común en el duelo —pecho pesado y nudo en la garganta son las sensaciones más universalmente relatadas—. La concentración en el estómago y el abdomen suele acompañar la ansiedad anticipatoria asociada al duelo. Las sensaciones en las manos y los brazos pueden relacionarse con el enojo no expresado. Cuando el niño no logra identificar ninguna sensación en el cuerpo —la silueta queda en blanco—, eso indica una disociación somática significativa: el niño está desconectado de las sensaciones físicas de su propio cuerpo como mecanismo de protección contra el sufrimiento. En esos casos, el trabajo de reconexión somática debe preceder a cualquier técnica expresiva más directa.

Preguntas orientadoras

- Cuando pensás en [nombre], ¿dónde sentís algo en el cuerpo?
- ¿Esa sensación tiene un color? ¿Un peso? ¿Una temperatura?
- Cuando tenés añoranza, ¿tu cuerpo te avisa de alguna forma?
- ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que parece cargar más el duelo?
- ¿Qué necesitaría esa parte de tu cuerpo para quedar un poco más liviana?

Adaptaciones

Para niños con quejas somáticas muy frecuentes (dolores de cabeza o de panza recurrentes): use el mapeo específicamente para las quejas presentadas. «Tenés mucho dolor de panza desde que [nombre] se fue. Mostrame en la silueta cómo es ese dolor». Eso tiende un puente entre el síntoma somático y el contenido emocional del duelo.

Para niños más pequeños (4 a 5 años): simplifique a un único mapeo —«¿dónde sentís la añoranza?»— sin trabajar múltiples emociones. La silueta puede ser del tamaño real del niño, trazada en papel kraft, lo que aumenta mucho el enganche.

TIPO	Técnica de procesamiento de imágenes intrusivas adaptada para niños en duelo traumático
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo traumático — niño con exposición a la escena de la muerte, al accidente, o que construye imágenes intrusivas sobre circunstancias que no presenció pero imagina con intensidad
DURACIÓN	45 a 50 minutos — requiere vínculo terapéutico bien establecido
MATERIALES	Hojas en blanco, marcadores, materiales para dibujo

Objetivo

Procesar las imágenes intrusivas que perpetúan el sufrimiento traumático en niños que vivieron un duelo con componente de trauma —ya sea por exposición directa a la escena de la muerte o por construcción imaginaria intensa de circunstancias no presenciadas—. El duelo traumático —cuando la muerte es súbita, violenta o con exposición del niño a escenas perturbadoras— tiene una capa de trauma que se superpone al duelo y debe procesarse antes de que el duelo propiamente dicho pueda avanzar. Las imágenes intrusivas (flashbacks, pesadillas, recuerdos que invaden la mente involuntariamente) son un síntoma central del TEPT y, en el duelo traumático, mantienen al niño atrapado en el momento de la muerte en lugar de permitirle avanzar hacia la elaboración de la pérdida. Este recurso, adaptado de técnicas de procesamiento de trauma para niños, usa el dibujo para externalizar, contener y modificar las imágenes intrusivas —no para borrarlas, sino para que el niño recupere alguna sensación de control sobre el contenido que lo invade—.

Cómo aplicar

1

Evaluación y preparación (10 min)

Antes de proponer cualquier trabajo con la imagen intrusiva, evalúe: ¿el niño tiene recursos de regulación suficientes para acceder al contenido sin ser desbordado? Si no hay una respuesta de regulación establecida (respiración, ancla corporal, palabra de parada), instálela primero. Diga: «Hoy vamos a mirar algo que te viene a la cabeza sin que lo llares. Lo vamos a hacer despacio, y vos manejas el ritmo. En cualquier momento que quieras parar, lo decís y paramos». La autonomía del niño sobre el ritmo es una condición innegociable.

2

Externalización de la imagen (15 min)

Pida que el niño dibuje la imagen que le viene —como aparezca, aunque sea aterradora, aunque sea fragmentada—. «No tiene que ser lindo. Es solo sacar lo que está dentro de la cabeza y ponerlo en el papel». Durante el dibujo, permanezca presente sin hablar mucho. Al terminar, el niño describe lo que dibujó: «Contame qué hay acá». La descripción en voz alta ya es un acto de procesamiento.

3

Modificación de la imagen (15 min)

Pregunte: «Si pudieras cambiar algo en esa escena —agregar a alguien, cambiar lo que pasa, ponerte en otro lugar—, ¿qué cambiarías?». Permita que el niño modifique el dibujo. Esa modificación no niega lo que pasó: crea una versión alternativa que el niño controla. Pregunte: «¿Cómo te sentís ahora mirando esta versión?». El objetivo es que la imagen modificada empiece a competir con la imagen intrusiva original en la memoria del niño.

4

Contención y regulación posactivación (10 min)

Después del trabajo con la imagen, cierre siempre con una práctica de regulación: respiración, movimiento suave, foco en algo agradable del ambiente. Nunca termine la sesión inmediatamente después de activar contenido traumático. Diga: «Hoy hiciste algo muy valiente. Antes de irnos, vamos a hacer algo para ayudar al cuerpo a volver a un lugar más tranquilo».

Lectura clínica

Este es uno de los recursos de mayor complejidad clínica del kit. Evalúe con criterio antes de aplicarlo: el niño necesita vínculo terapéutico establecido, recursos mínimos de regulación y ausencia de disociación activa. Señales de que no es el momento: un niño que se disocia al mencionar la imagen, que entra en estado de congelamiento, que no logra regularse al final de la sesión. Si esas señales aparecen durante el trabajo, deténgase y priorice la regulación. El procesamiento del trauma en el duelo debe ser gradual: las sesiones que activan más de lo que el sistema de regulación del niño soporta hacen más mal que bien. Considere supervisión clínica al trabajar con duelo traumático grave.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay alguna imagen sobre lo que pasó que te viene a la cabeza sin que quieras?
- ¿Esa imagen aparece más en algún momento: antes de dormir, en la escuela, en el silencio?
- Cuando viene esa imagen, ¿qué hacés con ella?
- Si pudieras cambiar algo de esa escena, ¿qué cambiarías primero?
- Después de dibujar esto, ¿cómo te estás sintiendo en el cuerpo ahora?

Adaptaciones

Para duelo por suicidio con exposición a la escena: este recurso requiere adaptación cuidadosa y evaluación de TEPT asociado. Derive a supervisión clínica específica antes de aplicarlo.

Para imágenes intrusivas construidas por la imaginación (niño que no presenció pero creó imágenes): el trabajo es similar pero con menor carga de activación traumática; a menudo la externalización y la modificación son suficientes para reducir la intrusión.

Para niños que se niegan a dibujar la escena («no quiero sacarlo afuera»): respételo. La negativa es una defensa legítima. Trabaje primero los recursos de regulación y la tolerancia a la activación antes de intentar la externalización.

TIPO	Técnica de elaboración del duelo a través de la relación del niño con los espacios físicos cargados de memoria
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo con dificultad para manejar los espacios físicos del fallecido — niño que no logra entrar en el cuarto, que evita su silla en la mesa, que siente presencia o ausencia intensa en ciertos lugares de la casa
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Plano simple de la casa dibujado u hoja en blanco para bosquejar, marcadores de colores

Objetivo

Trabajar la relación del niño con los espacios físicos cargados de memoria del fallecido, una dimensión del duelo a menudo descuidada en el trabajo clínico pero enormemente presente en el cotidiano. El ambiente físico es uno de los activadores más poderosos de memoria y de duelo: el olor del cuarto del padre, la silla vacía en la mesa, el lugar en el sillón donde miraban TV juntos. Para los niños, esos espacios tienen una concreción que las abstracciones del duelo no tienen, y la relación con ellos puede variar mucho: evitación total (no logro entrar al cuarto), hiperapego (quiere dormir en el cuarto del fallecido, mantener todo igual) o ambivalencia (entra pero sale corriendo). Ninguna de esas respuestas es patológica en sí misma; lo que importa clínicamente es el nivel de sufrimiento y la posibilidad de resignificación gradual. Este recurso usa el mapeo de los espacios de la casa como entrada al trabajo de memoria, presencia simbólica y transformación gradual.

Cómo aplicar

1

Mapeo de los espacios de la casa (15 min)

Pida que el niño dibuje (o describa mientras usted bosqueja) los ambientes de la casa. Para cada uno, pregunte: «¿[nombre] estaba mucho en este lugar? ¿Tenés algún recuerdo fuerte de este ambiente?». Marque con colores: verde para lugares donde la presencia es buena de recordar, rojo para los que se volvieron difíciles de frecuentar, amarillo para los que cambiaron desde la pérdida. Ese mapeo revela la geografía emocional del duelo en la vida cotidiana.

2

El lugar más difícil (15 min)

Identifique el lugar marcado como más difícil. Explórelo con cuidado: «Contame sobre ese lugar. ¿Qué pasa cuando pasás por ahí? ¿Qué sentís?». No fuerce al niño a «superar» la dificultad: primero comprenda qué representa. El cuarto del fallecido al que el niño no logra entrar puede representar el lugar donde ocurrió la muerte, el de mayor intimidad perdida, o el último espacio donde el fallecido todavía «existe» de forma concreta.

3

Qué hacer con el lugar (10 min)

Pregunte: «¿Qué te gustaría que pasara con ese lugar? ¿Que quede igual, que cambie, que se convierta en un lugar para recordar?». No imponga una respuesta. Algunos van a querer que el cuarto del padre se vuelva un memorial con sus cosas; otros, que cambie por completo; otros no saben todavía —y no saber es una respuesta válida—. El objetivo es que el niño tenga voz sobre la transformación del espacio, en lugar de que los adultos decidan por él.

4

Ritual de reconexión con el espacio (5 min)

Para niños que evitan por completo un espacio cargado: proponga un ritual gradual de reconexión —no entrar de golpe, sino detenerse en la puerta y decirle algo al fallecido, llevar un objeto que lo represente, o entrar solo dos minutos con alguien de apoyo—. La reconexión gradual con los espacios es parte de la elaboración del duelo: no tiene que ser rápida, pero tiene que empezar.

Lectura clínica

La forma en que el niño describe los espacios físicos de la casa revela mucho sobre la dinámica familiar en torno al duelo. Una casa donde todas las pertenencias del fallecido se retiraron rápidamente indica una familia que procesa el duelo por el borramiento, lo que suele dejar al niño sin anclas físicas de memoria. Una casa donde nada se tocó en meses indica una cristalización del duelo que puede estar impidiendo el movimiento de todos. Observe también si el niño menciona nuevos elementos en los espacios (pertenencias de la nueva pareja del progenitor sobreviviente, reformas) y cómo los procesa: la reorganización física del espacio suele anteceder o seguir a la reorganización familiar, y el niño tiene opiniones fuertes al respecto que rara vez se consultan.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay algún lugar de tu casa que quedó distinto después de que [nombre] se fue?
- ¿Hay algún lugar que evitás? ¿Qué pasa cuando pasás cerca?
- ¿Hay algún lugar de la casa donde sentís que [nombre] todavía está de algún modo?
- El cuarto/silla/lugar de él, ¿qué te parece que debería pasar con ese lugar?
- ¿Hay algún lugar adonde vas cuando sentís mucha añoranza?

Adaptaciones

Para niños que perdieron al progenitor en una muerte ocurrida en casa: el espacio donde ocurrió la muerte puede necesitar un trabajo específico de desensibilización y resignificación, posiblemente incluyendo una visita guiada al espacio con la psicóloga, si el contexto lo permite.

Para familias que se mudaron tras la pérdida: el duelo por los espacios antiguos puede ser tan significativo como el duelo por la persona. Pregunte por la casa anterior: qué extraña el niño de ese espacio específicamente.

TIPO	Protocolo de preparación y apoyo para el regreso escolar posduelo
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo reciente con regreso escolar inminente o reciente — niño ansioso por la vuelta, que ya volvió y tiene dificultades de adaptación, o que se niega a ir
DURACIÓN	40 a 50 minutos — más orientación a la familia y comunicación con la escuela
MATERIALES	Hoja de preparación, lista de acuerdos con la escuela

Objetivo

Preparar activamente al niño para el regreso al ambiente escolar tras la pérdida, un momento de alta vulnerabilidad que a menudo no recibe atención clínica específica. La escuela es el principal contexto social del niño en duelo fuera de casa, y el regreso tras la muerte de un familiar cercano está lleno de desafíos concretos: cómo responder cuando los compañeros pregunten, qué hacer si llora en clase, cómo manejar al docente que no sabe qué decir, cómo estar en un ambiente de normalidad cuando nada parece normal. Sin preparación, los niños suelen enfrentar esos momentos de forma aislada y humillante —el llanto frente a compañeros que no saben cómo reaccionar, la pregunta inocente de un compañero que no sabía de la muerte—. Con preparación, el niño entra a la escuela con un conjunto de respuestas planeadas, una persona de referencia acordada y la sensación de que no lo van a tomar por sorpresa. Esa preparación reduce mucho la ansiedad del regreso y las conductas de evitación escolar.

Cómo aplicar

1

Mapeo de los miedos sobre el regreso (10 min)

Pregunte directamente: «¿Qué tenés miedo de que pase cuando vuelvas a la escuela?». Liste todo lo que el niño trae sin minimizar. Miedos comunes: que los compañeros pregunten sobre la muerte, llorar delante de todos, que la maestra diga algo que lo ponga triste, no poder prestar atención en nada, sentir que todo es diferente. Para cada miedo, diga: «Ese miedo tiene todo el sentido. Vamos a pensar cómo manejarlo».

2

El guion de respuestas (15 min)

Para cada situación temida, construyan juntos una respuesta que el niño pueda usar. Ejemplos: cuando un compañero pregunte «¿qué le pasó a tu papá?» — «Mi papá murió. No quiero hablar de eso ahora, pero gracias por preguntar». Cuando sienta que va a llorar — «¿Puedo ir al baño un momento?». Cuando la maestra diga algo que active la tristeza — «¿Me podés dar un minuto?». Practique las respuestas en role play hasta que salgan naturales. El ensayo reduce la carga cognitiva en el momento real.

3

La persona de referencia en la escuela (10 min)

Identifique con el niño un adulto de confianza en la escuela —la maestra, la coordinadora, la auxiliar—. Oriente a la familia a comunicar previamente a ese adulto sobre la pérdida y sobre su papel de ser la persona de referencia. acuerde con el niño: «Si en cualquier momento se pone muy difícil, podés ir hasta [nombre] y decir que necesitás un momento». Tener un adulto acordado en la escuela transforma un ambiente potencialmente hostil en uno con al menos un punto seguro.

El acuerdo para el primer día (5 min)

Planifique el primer día de vuelta de forma concreta: quién lo lleva, qué pasa si necesita irse antes, qué va a hacer después de la escuela para reconectar. Diga: «El primer día va a ser el más difícil. Después se hace más fácil. Ya hiciste cosas difíciles antes: esta es una más».

Lectura clínica

Observe la naturaleza de los miedos que el niño identifica. Los miedos ligados a la exposición social (llorar delante de otros, no saber qué responder) son los más comunes y responden bien a la preparación de guiones. Los ligados a la incapacidad de funcionar normalmente («no voy a poder aprender nada», «no me voy a poder concentrar») reflejan el impacto cognitivo del duelo, que debe validarse con la escuela. La negativa escolar persistente más allá del período de regreso inmediato puede indicar duelo complicado, ansiedad de separación del progenitor sobreviviente, o un problema escolar previo amplificado por la pérdida. Investigue cada hipótesis antes de concluir cuál es la causa.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué es lo que más miedo te da que pase cuando vuelvas a la escuela?
- ¿Qué les vas a decir a los compañeros si preguntan qué pasó?
- ¿Hay algún amigo de la escuela que ya sabe lo que pasó? ¿Cómo fue cuando supiste que sabía?
- ¿Hay algún adulto en la escuela con quien te sentís seguro?
- Si pudieras elegir cómo se enteraron tus compañeros de la noticia, ¿cómo hubieras preferido que fuera?

Adaptaciones

Para niños cuyo duelo fue muy difundido en la escuela (muerte con cobertura, muy comentada): el regreso puede traer sobreexposición y exceso de atención, tan difícil de manejar como el aislamiento. Prepare guiones para manejar el exceso de atención además de la ausencia.

Para niños que ya volvieron y están teniendo dificultades: use la sesión para procesar lo que ya pasó antes de preparar los próximos días. No salte al futuro antes de procesar lo vivido.

TIPO	Exploración terapéutica de la dimensión espiritual del duelo sin imposición de creencias
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Cualquier niño en duelo — especialmente los de familias religiosas, los que tienen preguntas sobre el más allá, y aquellos cuya fe está siendo sacudida o reforzada por el duelo
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja en blanco, marcadores, papel para escribir preguntas

Objetivo

Explorar e integrar la dimensión espiritual y religiosa del duelo del niño, sin imponer creencias, sin confrontar la cosmología de la familia y sin reducir la fe a un mero mecanismo de afrontamiento. El duelo infantil tiene una dimensión espiritual inevitable: la muerte levanta preguntas sobre qué pasa después, adónde fue la persona, si está bien, si puede oír al niño. Para niños de familias religiosas, esas preguntas tienen respuestas que la comunidad de fe ofrece, y esas respuestas pueden ser enormemente reconfortantes o, al contrario, generar culpa y miedo («fue al purgatorio porque pecó»). Para niños de familias sin religiosidad, las preguntas quedan sin respuesta institucional y pueden ser especialmente aterradoras. El terapeuta no tiene el rol de responder las preguntas espirituales: su rol es crear espacio para que el niño explore qué cree, qué siente sobre lo que cree, y qué están haciendo las creencias de la familia con su duelo: sosteniéndolo o complicándolo.

Cómo aplicar

1

Abrir el espacio espiritual (5 min)

Pregunte con cuidado y sin presuponer: «¿Pensás en dónde está [nombre] ahora?». No diga «¿creés en algo?», porque puede sonar a prueba. La pregunta sobre dónde está es más concreta y abre el espacio espiritual de forma más natural. Acoja lo que venga sin concordar ni discrepar: «Contame más sobre eso».

2

El mapa de lo que el niño cree (20 min)

Pida que el niño dibuje o describa qué imagina que pasa después de la muerte —el lugar donde está [nombre], qué está haciendo, si puede verlo, si puede oírlo—. No evalúe la cosmología: explore con curiosidad genuina. Pregunte: «¿Alguien te enseñó esto? ¿La familia cree en esto? ¿Y vos, vos lo creés?». La distinción entre lo que cree la familia y lo que cree el niño de verdad es clínicamente importante.

3

Las preguntas que la creencia no responde (15 min)

Pregunte: «¿Hay algo sobre lo que pasó que no lográs entender ni con todo lo que creés? ¿Hay algo en lo que creés que en realidad te asusta en lugar de consolarte?». Esas preguntas acceden a dónde la religiosidad sostiene el duelo y dónde lo complica. La creencia de que el fallecido «se fue porque Dios quiso» puede generar un enojo con Dios que el niño no tiene permiso de expresar. La creencia de que «está en el cielo» puede coexistir con el miedo a que no lo esté. Acoja ambas dimensiones.

Qué ofrece la creencia (5 min)

Identifique con el niño qué ofrece la dimensión espiritual de concreto para el duelo: un lugar para hablar con el fallecido (la oración), una explicación para la muerte, una promesa de reencuentro, una comunidad de pertenencia. Fortalezca lo que está sosteniendo sin imponer lo que el niño no cree de verdad.

Lectura clínica

Observe la coherencia entre lo que el niño dice creer y lo que demuestra creer emocionalmente. Un niño que dice «está en el cielo y está bien» pero muestra ansiedad intensa e imágenes intrusivas sobre el estado del fallecido tiene un conflicto entre la creencia declarada y la creencia emocional que necesita atención. El enojo con Dios es un contenido frecuente y silenciado: los niños de familias religiosas rara vez se permiten expresarlo por miedo al castigo o a empeorar la situación del fallecido. Cuando aparece, valide con cuidado: «Muchas personas que creen en Dios también se enojan con él cuando pierden a alguien que aman. Eso no arruina la fe; a veces es parte de ella».

Preguntas orientadoras

- ¿Pensás en dónde está [nombre] ahora? ¿Qué te imaginás?
- ¿Tu familia cree en algo sobre lo que pasa después de la muerte? ¿Y vos?
- ¿Hay algo en lo que creés que te da consuelo? ¿Y algo que te asuste?
- ¿Hablás con [nombre] de alguna forma: por oración, en pensamiento, en voz alta?
- ¿Te enojaste con Dios, con la vida, con alguna fuerza mayor cuando [nombre] se fue?

Adaptaciones

Para niños de familias sin religiosidad: no imponga vocabulario espiritual. Trabaje las preguntas sobre el más allá con honestidad sobre lo que no se sabe, y explore lo que el niño cree de forma genuina —muchos niños desarrollan cosmologías personales independientes de la religiosidad familiar—.

Para niños de familias con creencias que generan culpa o miedo en relación con la muerte (purgatorio, karma, muerte como castigo): no confronte directamente la creencia religiosa de la familia. Trabaje el componente de culpa y miedo como emociones a elaborar, sin atacar la estructura de creencia que sostiene a la familia.

TIPO	Ritual terapéutico de comunicación intrafamiliar entre hermanos sobre la pérdida compartida
EDAD	5 a 10 años — sesión conjunta con dos o más hermanos en fase más avanzada del proceso
DEMANDA	Duelo que avanzó individualmente pero aún no se compartió en la fratría — hermanos que hablan con la psicóloga pero no entre sí sobre el fallecido
DURACIÓN	50 a 60 minutos
MATERIALES	Hojas individuales, marcadores, una hoja grande colectiva, vela opcional para el ritual

Objetivo

Crear un ritual estructurado de comunicación sobre el duelo entre hermanos. A diferencia del recurso 22, que se centra en el mapeo de las diferencias individuales, este se centra en construir una narrativa compartida y un momento de memoria colectiva. Mientras el recurso 22 es más adecuado para las fases iniciales, este se indica para cuando cada hermano ya tiene alguna elaboración individual y está listo para compartir el duelo de forma más intencional. La ausencia de comunicación sobre el duelo entre hermanos es un factor de riesgo: cada uno procesa aislado, puede desarrollar narrativas conflictivas sobre el fallecido y sobre la pérdida, y pierde el apoyo mutuo que la fratría podría ofrecer. Este recurso crea un momento formal y seguro para que el duelo salga del espacio privado de cada uno y se vuelva también algo compartido, lo que es en sí mismo un acto de elaboración colectiva.

Cómo aplicar

1

El recuerdo favorito de cada uno (15 min)

Pida que cada hermano escriba o dibuje en una hoja individual su recuerdo favorito del fallecido, sin mostrárselo al otro todavía. Cuando todos terminen, cada uno lo comparte. No corrija ni compare los recuerdos: cada uno es válido. Observe: ¿los recuerdos son del mismo período?, ¿del mismo tipo de experiencia?, ¿o completamente distintos? Las diferencias revelan cómo cada hermano vivió la relación de forma única.

2

Qué quiere cada uno que el otro sepa (15 min)

Pida que cada hermano complete: «Algo que quiero que sepas sobre cómo estoy es...» y «Algo que necesitaría de vos es...». Compartan por rondas. Usted facilita sin interpretar: solo garantiza que cada uno sea escuchado sin interrupción. Este ejercicio suele revelar pedidos que los hermanos nunca se hicieron directamente.

3

El memorial colectivo (15 min)

En la hoja grande colectiva, todos los hermanos construyen juntos un memorial para el fallecido: cada uno agrega algo —una palabra, un dibujo, un recuerdo escrito—. El resultado es un documento colectivo de la fratría. Puede volverse un cartel para la casa o quedar en el consultorio como hito del momento.

El ritual de la fratría (5 min)

Proponga que los hermanos acuerden un ritual regular entre ellos, sin necesidad de un adulto. Puede ser muy simple: cada domingo a la noche cada uno cuenta un recuerdo del fallecido, o encienden una vela en su cumpleaños juntos, o miran el memorial colectivo cada semana. El ritual crea continuidad del duelo compartido más allá de la sesión.

Lectura clínica

Observe la dinámica de poder y de cuidado que emerge entre los hermanos. Un hermano que minimiza consistentemente el duelo de los otros («ya no tenés que llorar, hace tiempo») revela su propia defensa más que sabiduría. Un hermano que queda en silencio observando a los otros puede estar en un duelo más profundo del que demuestra, o en un rol de cuidador que no le permite mostrar el propio. Facilite especialmente la expresión de los más silenciosos. Cuando emerge un conflicto entre hermanos durante la sesión sobre detalles de la muerte o sobre recuerdos del fallecido («me quería más a mí», «yo estaba con él al final»), no intente resolver quién tiene razón: use el conflicto como entrada al trabajo de ambivalencia y de disputa por la pertenencia en la pérdida.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay algún recuerdo de [nombre] que te parece que solo vos tenés, que tu hermano no vivió?
- ¿Te parece que tu hermano entiende lo que estás pasando?
- ¿Hay algo que te gustaría decirle a tu hermano sobre [nombre] que nunca le dijiste?
- ¿Cómo hablan de [nombre] en casa: hablan, o es un tema que no aparece?
- ¿Qué te parece que a [nombre] le gustaría que hicieran juntos?

Adaptaciones

Para fratrías con gran conflicto previo: no haga la sesión conjunta si hay hostilidad activa entre los hermanos. El conflicto va a interferir con el trabajo de duelo y puede resultar en más aislamiento. Trabaje el conflicto individualmente primero.

Para hijo único que perdió a otro hermano (y no al progenitor): adapte por completo el encuadre —el duelo del hijo único tiene dinámicas específicas de soledad irremediable, distintas del duelo compartido en la fratría—.

TIPO	Intervención terapéutica para el duelo anticipatorio en niños con un familiar en enfermedad terminal
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Niño con un familiar en enfermedad grave y prolongada — duelo que empieza antes de la muerte, con ambivalencia entre querer que la persona mejore y ya estar sintiendo la pérdida
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja dividida en dos partes, marcadores, papel para carta

Objetivo

Trabajar el duelo anticipatorio —el proceso de elaboración de la pérdida que empieza antes de la muerte, durante la enfermedad prolongada— que tiene características clínicas específicas distintas del duelo posmuerte. Los niños que acompañan la enfermedad larga de un familiar viven una forma particular de duelo: la persona está presente pero ya se está perdiendo, el vínculo se mantiene pero bajo enorme tensión, y el niño suele oscilar entre la esperanza de cura y la anticipación de la pérdida de un modo muy confuso y agotador. El duelo anticipatorio incluye también la pérdida del familiar tal como era antes de la enfermedad: la madre que antes corría en el parque y ahora está postrada, el padre que antes jugaba y ahora está demasiado cansado para hacerlo. Esa pérdida anticipada de funciones y de cualidades relacionales necesita espacio terapéutico antes de que ocurra la muerte, y el trabajo hecho en esta fase facilita mucho el duelo posterior.

Cómo aplicar

1

Nombrar lo que está pasando (10 min)

Empiece validando la complejidad: «Estás viviendo algo muy difícil: la persona que querés todavía está acá, pero ya está distinta. Y ya estás sintiendo la falta de algunas cosas, aunque ella esté presente. Eso tiene un nombre: duelo anticipado. No está mal sentirlo. Es tu corazón preparándose y, al mismo tiempo, luchando contra lo que puede venir».

2

Lo que ya se perdió y lo que todavía está (15 min)

Divida la hoja en dos campos: «Lo que todavía está acá» y «Lo que ya cambió». Para cada campo, el niño escribe o dibuja aspectos del familiar: qué todavía pueden hacer juntos, cómo se relacionan aún; y qué cambió con la enfermedad, qué ya perdieron antes de la muerte. Ese mapeo honra tanto la presencia como la pérdida ya en curso, sin forzar al niño a elegir entre esperanza y aceptación.

3

Qué quiere hacer el niño mientras todavía es posible (15 min)

Pregunte: «¿Hay algo que querés hacer, decir o vivir con [nombre] mientras todavía es posible?». No fuerce ninguna respuesta, pero si hay algo, trabaje el plan concreto para que ocurra. A veces es algo simple: ver juntos una película favorita, mostrarle un dibujo, pedirle una historia de su infancia. La psicóloga puede ayudar a la familia a crear las condiciones para que ese momento suceda.

Preparar preguntas para el familiar enfermo (5 min)

Si el niño tiene acceso al familiar y este está en condiciones, pregunte: «¿Hay alguna pregunta que quieras hacerle a [nombre] mientras podés?». Algunos quieren saber historias de la familia, otros si el familiar los va a extrañar, otros decir que lo quieren. Facilite el acceso a ese momento cuando sea clínicamente adecuado y acordado con la familia.

Lectura clínica

Observe cómo equilibra el niño esperanza y aceptación. Un niño que niega por completo la posibilidad de la muerte puede estar en una evitación que volverá el duelo posterior más abrupto. Un niño que ya «se resignó» y trata al familiar como si ya hubiera muerto puede estar protegiéndose de un modo que le impide aprovechar el tiempo que todavía existe. Ambas posiciones merecen trabajo. Observe también cómo comunica la familia sobre la enfermedad: los niños que no conocen la gravedad real porque los adultos los «protegen» serán tomados por sorpresa por la muerte de forma mucho más intensa. Oriente a la familia sobre la importancia de una comunicación honesta y adaptada a la edad.

Preguntas orientadoras

- ¿Cómo te estás sintiendo sobre lo que le está pasando a [nombre]?
- ¿Qué cambió entre ustedes dos desde que se enfermó?
- ¿Hay algo que quieras hacer con él mientras todavía es posible?
- ¿Cómo te sentís cuando pensás en el futuro?
- ¿Hay algo que los adultos alrededor no te cuentan y que te gustaría saber?

Adaptaciones

Para niños cuyo familiar muere durante el proceso terapéutico: no trate la muerte como una ruptura del proceso; use el trabajo del duelo anticipatorio como base para el duelo posterior. Lo elaborado antes no hay que rehacerlo: es fundamento para la próxima fase.

Para niños que piden visitar al familiar en el hospital o el hospice: no lo desaliente automáticamente. Una visita cuidadosamente preparada puede ser un recurso poderoso de despedida. Prepare al niño antes (qué va a ver, qué puede decir) y procese después.

TIPO	Construcción de memoria narrativa con niños que tienen un recuerdo limitado del fallecido
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo por un progenitor o familiar que murió cuando el niño era muy pequeño (antes de los 3 o 4 años) — niño que no tiene recuerdos propios pero siente la pérdida de forma presente e identitaria
DURACIÓN	40 a 50 minutos — puede incluir una sesión con un familiar que conoció al fallecido
MATERIALES	Hojas organizadas como álbum, marcadores, fotos traídas por la familia, papel para escribir

Objetivo

Trabajar el duelo específico de niños que perdieron a un progenitor o familiar muy cercano antes de consolidar recuerdos conscientes, una forma de duelo con características únicas que a menudo no recibe el reconocimiento que merece. Los niños que perdieron al padre antes de los 3 años no tienen recuerdos episódicos, pero tienen una pérdida real y presente: la ausencia de un padre en cada cumpleaños, la silla vacía en las reuniones familiares, la pregunta «¿dónde está tu papá?» que nunca tiene una respuesta simple. Estos niños suelen desarrollar una imagen del fallecido construida exclusivamente a partir de lo que otros cuentan, y esa imagen puede ser idealizada, fragmentada o distorsionada según lo que la familia permita compartir. El álbum incompleto trabaja dos aspectos: (1) construir una narrativa más rica e integrada del fallecido a partir de múltiples fuentes; (2) validar que es posible sentir duelo por alguien a quien no se recuerda —que la pérdida es real incluso sin recuerdos—.

Cómo aplicar

1

Lo que el niño sabe sobre el fallecido (10 min)

Pregunte: «¿Qué sabés sobre [nombre]? Contame todo». Registre lo que el niño sabe sin corregir ni complementar todavía. Después: «¿Cómo te enteraste de eso? ¿Quién te lo contó?». Ese mapeo revela las fuentes de información del niño sobre el fallecido y qué eligió compartir cada fuente, lo que informa mucho sobre la narrativa familiar en torno a la figura perdida.

2

Construcción del álbum con lo que existe (20 min)

Con las fotos traídas por la familia y lo que el niño sabe, construyan el álbum juntos. Cada página tiene una dimensión del fallecido: cómo era físicamente, qué le gustaba hacer, cómo era con el niño cuando era bebé, historias que la gente cuenta. Para cada página, distinga con el niño: «Esto lo sé porque me lo contaron» o «Esto lo tengo en una foto». Esa distinción ayuda al niño a entender cómo construye la imagen de quien no conoció.

3

Las páginas en blanco (10 min)

Al final del álbum, deje algunas páginas deliberadamente en blanco. Diga: «Estas páginas están en blanco porque hay cosas sobre [nombre] que no sabemos, que nadie contó o que nadie sabe. Ese espacio vacío es real. Podés escribir las preguntas que tenés y que todavía no tienen respuesta». Las páginas en blanco con preguntas escritas son una forma de honrar lo inaccesible sin fingir que el álbum está completo.

Quién puede llenar más páginas (5 min)

Identifique con el niño quién en la familia conoció bien al fallecido y podría ser invitado a una sesión de «contar historias». Abuelos, tíos, amigos cercanos suelen ser reservorios de recuerdos del fallecido que nunca llegaron al niño. Facilite ese acceso cuando sea clínicamente adecuado.

Lectura clínica

Observe la imagen que el niño tiene del fallecido: si es idealizada al extremo, distorsionada negativamente, o genuinamente compleja. La imagen que el niño construyó sin recuerdos propios es básicamente el resultado de lo que la familia decidió compartir y cómo. Una familia que idealizó al fallecido le dio al niño una imagen irreal con la que no es posible tener una relación interna auténtica. Una familia que silenció al fallecido dejó al niño sin base para construir imagen alguna. Ambas situaciones merecen trabajo. Observe también la intensidad de la pérdida identitaria: el niño que siente que «no tiene papá» de forma muy presente en el cotidiano (en la escuela, en las fiestas, en los documentos) necesita trabajo específico sobre identidad y pertenencia familiar.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué sabés sobre [nombre]? ¿Cómo te enteraste?
- ¿Hay algo que quisieras saber sobre él que nadie te contó nunca?
- ¿Extrañas a alguien que no recordás? ¿Cómo es esa sensación?
- ¿Te parece que sería distinto si lo hubieras conocido? ¿Cómo?
- ¿Hay alguien de la familia que te parece que puede contarte más sobre quién era?

Adaptaciones

Para niños que están descubriendo al fallecido por primera vez (familia que nunca habló): vaya despacio. Descubrir de golpe mucho contenido sobre un padre que nunca existió en la narrativa familiar puede ser abrumador.

Para niños con una imagen muy negativa del fallecido basada en narrativas de conflicto familiar: trabaje la humanización sin idealizar —el fallecido pudo tener dificultades reales y aun así tener aspectos con los que el niño puede identificarse o que puede valorar—.

TIPO	Elaboración del significado de las celebraciones familiares en ausencia del fallecido
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo con dificultad para celebrar — niño que no logra alegrarse en las fiestas, que siente culpa por divertirse, o que boicotea las celebraciones porque «no es justo festejar sin él»
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja con espacios para recuerdos, rituales y nuevas posibilidades, marcadores

Objetivo

Trabajar la relación del niño en duelo con las celebraciones familiares —cumpleaños, Navidad, actos, fiestas— que se vuelven momentos de dolor agudo por la ausencia del fallecido y por el conflicto entre la alegría social esperada y el duelo personal. Muchos niños desarrollan lo que puede llamarse «culpa de la alegría»: la sensación de que divertirse es una traición al fallecido, de que celebrar es inadecuado cuando alguien que amaban ya no está presente. Esa culpa puede llevar al boicot de las celebraciones, a la incapacidad de alegrarse incluso en momentos positivos, y al aislamiento social en torno a los eventos festivos. El recurso trabaja tres dimensiones: (1) validar que el dolor en las fiestas es real y esperable; (2) diferenciar celebrar de olvidar o traicionar; (3) construir formas de incluir al fallecido en la celebración para que la fiesta pueda ocurrir sin que el niño tenga que fingir que no lo extraña.

Cómo aplicar

1

La fiesta que se volvió difícil (10 min)

Pregunte por una celebración reciente que fue difícil: «¿Cómo fue tu último cumpleaños? ¿La Navidad? ¿Hubo un momento de la fiesta que se puso muy pesado?». Mappee lo que pasó emocionalmente, no solo el evento externo. Observe: ¿el niño se puso triste durante la fiesta, se fue temprano, no quiso ir, o fue pero se sintió culpable por divertirse?

2

La culpa de la alegría (10 min)

Si hay culpa por haberse divertido, trabájela directo: «¿Te parece que celebrar significa que te olvidaste de [nombre]? ¿O que no lo extrañas?». Después de la respuesta: «Celebrar y extrañar pueden pasar el mismo día. La alegría y la tristeza pueden coexistir. No tenés que quedarte triste toda la tarde para probar que querés a [nombre]». Normalice la ambivalencia sin minimizar el dolor.

3

Cómo incluir al fallecido en la celebración (15 min)

Pregunte: «¿Cómo te gustaría recordar a [nombre] en la próxima fiesta?». Construyan juntos un ritual de inclusión: una vela encendida con su nombre, una comida favorita suya en la mesa, una foto en el centro, un brindis en su memoria, un momento en que cada uno de la familia cuenta un recuerdo. El ritual de inclusión permite que el fallecido sea parte de la fiesta sin que la fiesta tenga que estar dominada por la tristeza.

Qué puede celebrar (5 min)

Pregunte: «¿Hay algo en tu vida, aun con todo esto, que puedas celebrar?». No fuerce la positividad: si ahora no hay nada, acójalo. Pero si hay algo pequeño —una amistad, un logro, un momento de alegría— valide que también es real y merece ser honrado. El fallecido a menudo habría querido que el niño se alegrara.

Lectura clínica

La incapacidad de celebrar es un indicador de cuánto espacio está tomando el duelo en la vida del niño. Un niño que no logra alegrarse en ningún contexto festivo después de muchos meses puede estar en duelo complicado con componente depresivo: la anhedonia (incapacidad de sentir placer) debe evaluarse aparte del duelo. Un niño que logra alegrarse durante la fiesta pero después se siente culpable está en un proceso de elaboración activo: la culpa indica que el vínculo interno con el fallecido está preservado, lo que es sano. El trabajo es reducir la culpa, no ampliar la alegría. Observe también el papel de la familia en la dinámica de las fiestas: una familia que prohíbe la alegría («no es momento de fiesta», «¿cómo podés reírte?») transmite un mensaje poderoso que el niño está internalizando.

Preguntas orientadoras

- ¿Cómo fueron las fiestas después de que [nombre] se fue? ¿Qué fue lo más difícil?
- ¿Alguna vez te sentiste culpable por haberte divertido después de la pérdida?
- ¿Qué te parece que a [nombre] le gustaría que hicieras en las fiestas?
- ¿Cómo te gustaría que se recordara a [nombre] en las próximas celebraciones?
- ¿Hay algo en tu vida ahora, aun con todo, que puedas celebrar?

Adaptaciones

Para niños cuyo cumpleaños está cerca de la fecha de la muerte o del velatorio: el cumpleaños puede haberse cargado de una ambivalencia extrema. Trabaje ese día específico con mucho cuidado: el derecho del niño a celebrar su propio nacimiento no queda cancelado por la pérdida, pero puede necesitar apoyo explícito para ejercerse.

Para familias que dejaron de celebrar por completo tras la pérdida: incluya una conversación con el progenitor sobreviviente sobre el impacto del duelo de las fiestas en el desarrollo del niño, que necesita espacio para la alegría incluso en el duelo.

TIPO	Técnica de automonitoreo del enojo en el duelo con foco en canales de expresión cotidianos
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Duelo con enojo activo y recurrente en lo cotidiano — niño que ya trabajó el enojo de forma expresiva en sesión pero sigue explotando en casa y en la escuela, o que identifica el enojo pero no sabe qué hacer con él fuera del consultorio
DURACIÓN	30 a 35 minutos de presentación; uso continuo entre sesiones
MATERIALES	Cuadernito de registro, lapicera, lista de canales de salida acordados

Objetivo

Desarrollar con el niño un sistema de automonitoreo y expresión del enojo en lo cotidiano, complementario al Panel del Enojo (recurso 18), que ofrece una expresión intensa en sesión pero no cubre lo que el niño hace con el enojo los otros días de la semana. El enojo en el duelo es una emoción de alta activación que necesita un canal de salida regular, no solo en la sesión semanal o quincenal. Sin ese canal, se acumula y desborda de forma descontextualizada: el niño explota con el hermano por algo pequeño cuando en realidad está enojado por la muerte del padre. El recurso instala tres componentes: (1) reconocimiento —el niño aprende a identificar cuándo el enojo que siente es sobre el duelo o sobre otra cosa—; (2) registro —un diario breve que le da nombre al enojo y a lo que lo activó—; (3) canalización —una lista personalizada de canales de salida que el niño puede usar en el momento en que el enojo aparece—.

Cómo aplicar

1

El enojo del duelo versus otros enojos (10 min)

Explique: «No todo el enojo que sentís es sobre el duelo. Pero a veces te enojás por una cosa chiquita y en realidad el enojo que está por debajo es sobre [nombre]. Hoy vamos a aprender a darnos cuenta de cuándo pasa eso». Dé ejemplos concretos de la vida del niño: «¿Alguna vez te enojaste muchísimo por algo que normalmente no te irritaría tanto?». Esa pregunta suele acceder a episodios que el niño reconoce.

2

El cuaderno del enojo (10 min)

Presente el cuadernito: «Cada vez que sientas un enojo fuerte, escribís acá tres cosas: qué pasó (qué activó el enojo), qué estabas sintiendo antes (¿ya estabas triste, cansado, con añoranza?), y qué hiciste con el enojo. No tiene que ser largo: una línea para cada una». Practique en sesión con el último enojo que el niño recuerde.

3

El menú de canales de salida (10 min)

Construyan juntos una lista de cosas que el niño puede hacer cuando aparece el enojo fuera del consultorio: actividad física (correr, saltar, golpear un almohadón), expresión creativa (dibujar, tachar con fuerza), escritura (escribir en el cuaderno lo que siente), acción física segura (sacudir las manos con fuerza, respirar hondo tres veces). La lista es personalizada; no la imponga. Pregunte: «¿Qué te funcionó ya cuando estabas muy enojado?». Lo que el niño ya sabe que funciona es más poderoso que cualquier técnica nueva.

Lectura clínica

El patrón de registro en el cuaderno es dato clínico: un niño que registra enojos muy frecuentes e intensos tiene una alta carga de enojo no elaborado que necesita más trabajo en sesión. Un niño que rara vez registra puede tener el enojo inhibido —no porque no lo sienta, sino porque aprendió a no reconocerlo o a no nombrarlo—. Observe el patrón de disparadores: cuando el enojo del niño se activa consistentemente por situaciones específicas (ausencia del fallecido en eventos, comparaciones con compañeros que tienen al familiar vivo, comentarios de los adultos), esos disparadores necesitan trabajo específico en sesión además del registro cotidiano.

Preguntas orientadoras

- ¿Lográs darte cuenta de cuándo el enojo que sentís es sobre el duelo, no sobre lo que pasó recién?
- ¿Qué solés hacer cuando te enojás en lo cotidiano?
- ¿Te pasó de explotar por algo chiquito y después darte cuenta de que era otra cosa la que pesaba?
- De los canales de salida que listamos, ¿cuál te parece que vas a poder usar más fácil?
- ¿Qué te ayuda a no lastimar a nadie cuando estás muy enojado?

Adaptaciones

Para niños con comportamiento agresivo frecuente: el cuaderno de registro es un recurso de automonitoreo pero no reemplaza el trabajo de regulación emocional. Úselo junto con técnicas de regulación que prevengan la explosión antes de que ocurra.

Para niños que no quieren registrar en papel: ofrezca el registro por audio en el celular —el niño graba un mensaje de voz rápido describiendo el episodio de enojo—. Más accesible y rápido que escribir.

TIPO	Técnica de elaboración de la tolerancia a la incertidumbre y a lo incomprensible en el duelo
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Duelo con preguntas existenciales y sin respuesta — niño que sigue preguntando por qué la persona murió, por qué Dios lo dejó, si les va a pasar a otros, y no encuentra respuesta satisfactoria en ninguna explicación
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja grande, cajita o sobre para guardar las preguntas, marcadores

Objetivo

Crear un espacio terapéutico para las preguntas imposibles del duelo infantil —aquellas que no tienen respuesta satisfactoria y que, cuando los adultos intentan responderlas con explicaciones simplistas, a menudo aumentan el sufrimiento en lugar de reducirlo—. «¿Por qué murió?», «¿Por qué Dios se la llevó?», «¿Por qué esa persona mala no murió en lugar de mi papá?», «¿Le va a pasar también a mi mamá?»: esas preguntas expresan dolor, injusticia e incomprensión, no necesariamente una búsqueda de respuesta lógica. Cuando los adultos responden con «fue la voluntad de Dios», «le pasa a todo el mundo» o «no pienses en eso», están respondiendo a una pregunta factual cuando el niño está expresando una emoción. El recurso propone acoger las preguntas como lo que son —expresiones de dolor— sin intentar responderlas, y a la vez trabajar la capacidad de tolerar que algunas preguntas no tendrán respuesta, una habilidad emocional fundamental para atravesar el duelo.

Cómo aplicar

1

El espacio de las preguntas (5 min)

Presente: «Hay cosas sobre lo que pasó que no tienen respuesta. Y a veces, cuando hacemos esas preguntas, las personas intentan responder y la respuesta no ayuda para nada. Hoy quiero que escribas todas las preguntas que tenés sobre [nombre] y sobre lo que pasó, incluso las que creés que nadie puede responder. No vamos a intentar responderlas todas. Las vamos a mirar juntos».

2

Escribir las preguntas (15 min)

El niño escribe o dicta las preguntas —una por papel pequeño—. No limite la cantidad. No responda todavía: solo reciba. Para cada pregunta, refleje de vuelta la emoción: «Esta pregunta parece cargar mucha injusticia», «Esta parece cargar mucho miedo», «Esta parece cargar mucho enojo». Identificar la emoción por debajo de la pregunta es el trabajo clínico central.

3

Separar por tipo de pregunta (10 min)

Con las preguntas sobre la mesa, sepárenlas en tres grupos: preguntas que tienen respuesta y alguien puede responder (información sobre lo que pasó, hechos médicos); preguntas que tal vez nunca tengan una respuesta cierta (por qué él y no otro, qué pasa después de la muerte); preguntas cuya respuesta el niño ya sabe pero todavía no acepta emocionalmente. La separación ayuda al niño a distinguir la búsqueda de información de la expresión de dolor.

El cofre de las preguntas sin respuesta (10 min)

Las preguntas sin respuesta van a una cajita o sobre especial. Diga: «Estas preguntas no tienen respuesta. Pero necesitan un lugar. Este cofre es el lugar de ellas. De vez en cuando podemos abrirlo y ver si alguna cambió de grupo: si encontraste una respuesta o si la pregunta quedó distinta». Las preguntas con respuesta posible se vuelven agenda para la sesión con el progenitor sobreviviente.

Lectura clínica

La naturaleza de las preguntas imposibles que hace el niño es clínicamente diagnóstica. Preguntas predominantemente sobre justicia («por qué él y no otro») expresan enojo e injusticia: el trabajo es validar y elaborar el enojo. Preguntas predominantemente sobre culpa («¿hice algo que lo causó?», «¿se fue porque estaba enojado conmigo?») expresan culpa mágica: el trabajo es de reestructuración cognitiva de la culpa. Preguntas predominantemente sobre el miedo al futuro («¿mi mamá también va a morir?», «¿yo voy a morir antes de crecer?») expresan ansiedad anticipatoria: el trabajo es de contención y de distinción entre el miedo real y la probabilidad real. Cada tipo de pregunta apunta a un foco distinto del trabajo terapéutico.

Preguntas orientadoras

- ¿Hay alguna pregunta sobre lo que pasó que nadie logró responderte de un modo que ayudara?
- Cuando hacés estas preguntas, ¿buscás una respuesta o estás expresando cómo te sentís?
- ¿Hay alguna respuesta que te dieron que te dejó todavía más confundido o enojado?
- ¿Qué sentís cuando pensás que algunas de estas preguntas tal vez nunca tengan respuesta?
- ¿Hay alguna pregunta que tenías antes y que ahora parece menos urgente? ¿Qué cambió?

Adaptaciones

Para niños que hacen las mismas preguntas repetidamente sin recibir respuesta satisfactoria: investigue si la repetición es búsqueda de información o rumiación ansiosa. Si es rumiación, el trabajo es de regulación de la ansiedad, no de búsqueda de respuesta.

Para niños con preguntas sobre el suicidio del familiar: las preguntas sobre el «por qué» son especialmente intensas y a menudo dirigidas a la culpa propia. Trabaje con mucho cuidado, idealmente con orientación del progenitor sobreviviente sobre lo que puede y debe decirse.

TIPO	Técnica de normalización y reducción del aislamiento mediante la identificación con otros que vivieron pérdidas
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Duelo con intenso sentimiento de aislamiento — niño que siente que nadie entiende lo que está pasando, que ningún compañero puede imaginar cómo es, que está completamente solo en la experiencia
DURACIÓN	35 a 40 minutos
MATERIALES	Libros o historias sobre personajes que pasaron por un duelo, hojas para narrativa

Objetivo

Reducir el aislamiento del duelo infantil por la vía de la identificación con pares —reales o ficticios— que también pasaron por pérdidas, creando la experiencia de que el duelo no es algo único y solitario, sino algo que otros seres humanos también vivieron y atravesaron. El aislamiento es una de las experiencias más dolorosas del duelo infantil: el niño siente que está en un mundo distinto al de sus compañeros, que nadie logra entender, que no hay palabras que alcancen lo que está viviendo. Ese aislamiento es real —pocos niños de la misma clase habrán perdido a un progenitor—, pero puede aliviarse parcialmente con el contacto con historias de otros que vivieron pérdidas. Los libros de biblioterapia para el duelo, las historias de personajes que perdieron a sus padres temprano y las historias de pares que el niño puede conocer en grupos terapéuticos son recursos poderosos de des-aislamiento. El terapeuta no necesita pares reales para usar este recurso: la narrativa ficticia de un personaje que perdió a alguien y atravesó el duelo tiene el mismo poder de identificación.

Cómo aplicar

1

Nombrar el aislamiento (5 min)

Empiece con la experiencia del aislamiento: «¿Te sentís como si ningún compañero pudiera entender lo que estás viviendo? ¿Como si estuvieras en un mundo distinto al de ellos?». Valide: «Eso es real. Es muy difícil cuando vivimos algo que las personas alrededor no vivieron. Pero quiero mostrarte que otras personas también pasaron por esto, y lo atravesaron».

2

La historia de quien también perdió (15 min)

Presente una historia —ficticia o real— de un niño o personaje que pasó por una pérdida significativa. Léanla juntos o cuéntela. Después, pregunte: «¿Hay algo de esta historia que se parezca a lo que estás viviendo? ¿Algo que el personaje sintió que vos también sentiste?». No fuerce la identificación: deje que el niño encuentre los puntos de contacto. Cuando los encuentra, la identificación es profundamente des-aislante.

3

Qué aprendió el personaje (10 min)

Explore qué hizo el personaje con el duelo, cómo lo atravesó, qué lo ayudó. No como modelo a seguir, sino como evidencia de que el duelo tiene movimiento —de que es posible atravesarlo—. Pregunte: «¿Qué te parece que ayudó al personaje a seguir?» y «¿Hay algo de eso que podría ayudarte a vos también?».

4

Carta para el personaje (10 min)

Proponga que el niño escriba o dicte una carta para el personaje. Esa carta suele volverse una carta para sí mismo: lo que el niño le diría a un personaje en duelo es lo que él necesita escuchar. Cierre leyendo la carta en voz alta: es uno de los momentos más poderosos del recurso.

Lectura clínica

La forma en que el niño se identifica con el personaje en duelo es clínicamente informativa. Una identificación muy rápida e intensa puede indicar un aislamiento severo —el niño estaba muy necesitado de cualquier forma de compañía en la experiencia—. La dificultad de identificación («pero su situación es distinta, no es lo mismo») puede indicar que el niño protege su propio duelo de cualquier comparación, lo que a veces refleja una creencia de que su pérdida específica es inconmensurable e incomparable —lo cual es verdad y a la vez puede mantener el aislamiento—. La carta para el personaje casi siempre revela lo que el niño necesita decirse a sí mismo: preste especial atención al contenido de aliento y de permiso que le ofrece al personaje.

Preguntas orientadoras

- ¿Te sentís como si ningún compañero pudiera entender lo que estás pasando?
- ¿Hubo algo en la historia del personaje que se pareció a lo que estás viviendo?
- ¿Qué le dirías a un niño que está empezando a vivir lo que vos viviste?
- ¿Conocés a alguien —en la vida real o en alguna historia— que pasó por una pérdida y siguió adelante?
- ¿Qué te ayuda a no sentirte completamente solo en esta experiencia?

Adaptaciones

Referencias para biblioterapia del duelo infantil: «El pato y la muerte» (Wolf Erlbruch) y «El árbol de los recuerdos» (Britta Teckentrup) son clásicos accesibles sobre la pérdida para niños pequeños; para niños más grandes, historias donde un personaje pierde a alguien y sigue adelante. Elija materiales adecuados a la edad y a la circunstancia de la pérdida.

Para niños en grupos terapéuticos de duelo: el contacto con pares reales que pasaron por pérdidas similares es aún más poderoso que la biblioterapia; considere la derivación a grupos cuando estén disponibles.

TIPO	Psicoeducación y preparación para las reactivaciones normales del duelo a lo largo del desarrollo
EDAD	7 a 10 años — cercano a la fase de cierre del proceso
DEMANDA	Fase avanzada del acompañamiento — niño con elaboración significativa que se prepara para cerrar el proceso terapéutico
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Línea de tiempo del desarrollo, hoja de plan personal de manejo

Objetivo

Preparar al niño para un fenómeno normal, esperable y a menudo mal comprendido del duelo: la reactivación del proceso en momentos de transición o de hito en el desarrollo. El duelo infantil no sigue una trayectoria lineal de progresión hasta la resolución; tiene un carácter evolutivo, lo que significa que se reactiva en momentos clave de la vida: al entrar en la adolescencia, cuando los pares empiezan a tener relaciones amorosas (mientras el fallecido no estará presente en ese momento), cuando se recibe, cuando se casa, cuando tiene hijos. Cada transición trae de vuelta la conciencia de la ausencia con una nueva dimensión: «él no va a ver esto». Los niños que no fueron preparados para esto tienden a vivir las reactivaciones como un fracaso —«creía que lo había superado, ¿por qué estoy mal de nuevo?»—, mientras que los que fueron preparados las viven como parte normal de un proceso que se reconstruye a lo largo de la vida.

Cómo aplicar

1 El duelo que se mueve a lo largo de la vida (10 min)

Explique: «El duelo no es algo que sentís un tiempo y después se termina. Va cambiando a lo largo de tu vida. A veces vas a estar muy bien por meses y, de repente, en un momento importante —cuando cumplas 15, cuando te recibas, cuando tengas tu primera pareja— la añoranza va a volver con fuerza. Eso no significa que retrocediste. Significa que [nombre] sigue siendo parte de tu vida».

2 Mapear los momentos futuros (15 min)

Construyan una línea de tiempo del desarrollo del niño para los próximos 10 a 15 años: cuándo va a entrar en la adolescencia, cuándo va a terminar la secundaria, cuándo va a empezar a tener pareja, cuándo va a cumplir 18. Para cada momento, pregunte: «¿Qué te parece que vas a extrañar de [nombre] en ese momento?». Nombrar de antemano la ausencia específica en cada hito vuelve la reactivación futura más reconocible y menos aterradora.

El plan personal de manejo (10 min)

Construyan juntos un plan simple para cuando el duelo vuelva: cómo va a reconocer el niño que es una reactivación (no un retroceso), a quién va a buscar, qué va a hacer en los primeros días de intensidad, si va a buscar una sesión de retorno o si va a poder atravesarlo con lo que ya sabe. Diga: «No vas a estar solo en esos momentos. Vas a tener todo lo que aprendiste acá, y vas a tener personas que te quieren. Y si necesitás ayuda, podés volver».

El mensaje para el yo del futuro (5 min)

Proponga que el niño escriba un mensaje corto para sí mismo, para leer cuando el duelo vuelva: «Querido yo del futuro: cuando estés sintiendo la añoranza fuerte de nuevo, quiero que sepas que...». Ese mensaje, guardado junto con los materiales del proceso, es un documento de identidad que el niño accede cuando más lo necesita.

Lectura clínica

Observe cómo reacciona el niño ante la perspectiva de que el duelo va a volver. Un niño que se pone ansioso con esa información puede estar interpretando la reactivación como un fracaso inminente: trabaje más la normalización antes de finalizar. Un niño que reacciona con alivio («entonces no está mal cuando me pongo mal a veces») demuestra que ya estaba teniendo reactivaciones y sintiéndose culpable por ellas: la información tiene un efecto inmediatamente terapéutico. Observe también qué momentos anticipa el niño como más difíciles: los hitos que nombra con más carga emocional son los que más necesitan preparación específica —no ahora, pero pueden retomarse en sesiones futuras o en retornos—.

Preguntas orientadoras

- ¿Ya notaste que a veces estabas bien un tiempo y de repente la añoranza volvió fuerte?
- ¿Qué te parece que vas a extrañar de [nombre] cuando cumplas 15? ¿Cuando te recibas?
- Si dentro de cinco años te despertás con mucha añoranza, ¿qué vas a hacer?
- Saber que el duelo puede volver, ¿te deja más o menos preparado? ¿Por qué?
- ¿Qué le vas a decir a tu yo del futuro cuando el duelo vuelva?

Adaptaciones

Para niños cercanos a transiciones inmediatas (cambio de escuela, entrada en la adolescencia): el recurso es especialmente relevante porque la transición es inminente y la reactivación es previsible. Prepare con más especificidad para ese momento concreto.

Para niños que retornan al proceso después de un cierre anterior: use este recurso como ancla —«¿te acordás que hablamos de que el duelo podía volver? Estás viviendo eso ahora»—. Reconocer la reactivación como proceso normal reduce la vergüenza del retorno.

TIPO	Técnica de mapeo de los cambios concretos en la vida familiar tras la pérdida y su elaboración
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo con múltiples cambios simultáneos — niño que perdió al familiar y a la vez perdió la casa, la escuela, la rutina, el ingreso, el estilo de vida — acumulación de pérdidas secundarias que sobrecarga el proceso
DURACIÓN	40 a 50 minutos
MATERIALES	Hoja grande dividida en tres columnas: «Qué cambió», «Cómo me siento con eso», «Qué ayuda», marcadores

Objetivo

Trabajar las pérdidas secundarias que acompañan la muerte de un familiar cercano —los cambios prácticos, relacionales y materiales que suelen sumarse a la pérdida principal y sobrecargan el proceso de duelo de forma invisible—. La muerte de un progenitor rara vez ocurre aislada: suele venir acompañada de mudanza (la familia no puede sostener la casa con el ingreso de un solo adulto), cambio de escuela, pérdida de contacto con la familia del fallecido, cambio radical de rutina, disminución del ingreso familiar y, a veces, la entrada de nuevos adultos en la vida del niño. Cada uno de esos cambios es una pérdida adicional que necesita su propio espacio de elaboración, y que a menudo no lo recibe porque queda a la sombra de la pérdida principal. Los niños que acumulan muchas pérdidas secundarias tienden a presentar un duelo más complejo y difícil de elaborar: es como intentar procesar un duelo mientras el piso sigue moviéndose bajo los pies.

Cómo aplicar

1

Inventario de los cambios (15 min)

Recorran juntos las áreas de la vida del niño: vivienda, escuela, amigos, rutina, finanzas familiares, relación con la familia extensa, presencia de nuevos adultos. Para cada área: «¿Cambió algo acá después de que [nombre] se fue?». Registre en la columna «Qué cambió». No evalúe los cambios todavía: solo inventaríe. La cantidad de cambios que aparece suele sorprender al niño: no los había visto todos juntos.

2

Qué pesa más (15 min)

Con el inventario sobre la mesa, pregunte: «De todos estos cambios, ¿cuál es el que más pesa? ¿Cuál extrañas más de cómo era antes?». Complete la columna del medio con los sentimientos de cada cambio. Observe que a veces el cambio que más pesa no es el más obvio: el niño puede estar procesando bien la muerte pero sentir un dolor intenso por el cambio de escuela y la pérdida de amigos —y ese dolor necesitaba un nombre—.

3

Qué ayuda en cada cambio (10 min)

Para cada cambio identificado como pesado, pregunte: «¿Hay algo que ya esté ayudando? ¿Algo que podría ayudar?». Complete la tercera columna. Algunos cambios no tienen qué ayude —la casa nueva no va a volver a ser la de antes—. En ese caso, trabaje el duelo por ese cambio específico como una pérdida autónoma que merece elaboración.

Qué permaneció igual (5 min)

Cierre con una pregunta de anclaje: «En medio de tantos cambios, ¿hay algo que se mantuvo igual? ¿Algo que no cambió y que te da seguridad?». Identificar islas de continuidad en medio del cambio es una intervención de contención importante para niños con muchas pérdidas secundarias.

Lectura clínica

La cantidad y la naturaleza de las pérdidas secundarias son un indicador clínico de la complejidad del duelo. Un niño con muchas pérdidas secundarias simultáneas tiene una carga de elaboración mucho mayor que la pérdida principal aislada: la planificación terapéutica debe considerar ese acúmulo. Observe qué pérdida secundaria ubica el niño en la posición de mayor peso: cuando el cambio de escuela o de casa pesa más que la muerte en sí, no indica que el niño no esté en duelo, sino que la pérdida secundaria activó un dolor específico que merece su propio trabajo. La pérdida de los amigos, de la escuela, del barrio son pérdidas de vínculo genuinas que pueden ser tan impactantes como la del familiar.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué cambió en tu vida después de que [nombre] se fue?
- De todos esos cambios, ¿cuál pesa más? ¿Cuál extrañas más?
- ¿Hay algún cambio que te sorprendió, que no esperabas que fuera tan difícil?
- En medio de tanto que cambió, ¿hay algo que quedó igual y te da seguridad?
- Si pudieras revertir uno de esos cambios —solo uno—, ¿cuál elegirías?

Adaptaciones

Para niños en situación de vulnerabilidad social tras la pérdida (dificultades económicas severas, inestabilidad habitacional): el trabajo clínico debe articularse con apoyo social concreto; derive a recursos de protección social cuando sea necesario. El duelo no puede elaborarse en un vacío de inseguridad material.

Para niños que ganan nuevos miembros en la familia (nueva pareja del progenitor, nuevos hermanos): trabaje el cambio relacional específico como pérdida de exclusividad y de configuración familiar —sin invalidar la nueva configuración, pero honrando lo que cambió—.

TIPO	Ritual terapéutico de despedida simbólica para muertes súbitas o sin presencia del niño
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Duelo por muerte súbita, accidental o por enfermedad rápidamente fatal — niño que no pudo despedirse, no estaba presente en el momento de la muerte, o no fue al velatorio y lo carga como una pérdida adicional
DURACIÓN	50 a 60 minutos — requiere rapport establecido y un espacio emocional seguro
MATERIALES	Materiales variados según el ritual elegido con el niño: papel, vela, objeto significativo, carta

Objetivo

Crear un ritual terapéutico de despedida simbólica para niños que no tuvieron la oportunidad de despedirse del fallecido —sea porque la muerte fue súbita y no hubo aviso, sea porque el niño fue «preservado» del velatorio por los adultos, sea porque la muerte ocurrió lejos—. La ausencia de despedida es una de las fuentes más significativas de duelo complicado: el niño carga la sensación de que algo esencial quedó incompleto, de que hay palabras no dichas, de que la separación fue abrupta e injusta. Este recurso no deshace lo que pasó —ningún ritual simbólico puede reemplazar la despedida real—, pero puede ofrecer un espacio de cierre que la realidad negó, permitiendo que algo que quedó suspendido encuentre un desenlace. Basado en el trabajo de Worden sobre las tareas del duelo —específicamente la de aceptar la realidad de la pérdida— de forma procesada y con agencia del niño.

Cómo aplicar

1

Nombrar lo que no ocurrió (10 min)

Empiece con una conversación directa sobre la ausencia de la despedida: «No pudiste despedirte de [nombre]. Eso es muy difícil de cargar —la sensación de que algo quedó inconcluso, de que no tuviste la chance de decir lo que querías—. Pregunte: «¿Pensás en eso? ¿Qué te hubiera gustado haber dicho, hecho, o haber estado presente?». Mapee el contenido específico de lo que quedó sin espacio de expresión.

2

Qué sería una despedida para vos (10 min)

Pregunte: «Si hubieras podido despedirte, ¿cómo te imaginás que habría sido? ¿Qué habrías dicho? ¿Qué habrías hecho? ¿A quién te hubiera gustado que estuviera?». No romantice la despedida ideal: solo deje que el niño construya la versión que imaginaría. Ese proceso revela qué es lo que más extraña de no haber podido hacer.

3

Construcción del ritual de despedida (25 min)

Proponga crear juntos un ritual de despedida simbólica que contenga lo que quedó sin expresión. El ritual lo construye enteramente el niño; usted solo facilita. Elementos posibles: una carta leída en voz alta para el fallecido, un objeto del fallecido o del niño colocado en un lugar especial, una vela encendida con palabras dichas, un dibujo u objeto creado y después dejado en un lugar significativo. El ritual necesita un inicio, un desarrollo y un final: la estructura temporal es lo que crea la sensación de cierre.

El después del ritual (10 min)

Después del ritual, siéntese en silencio un momento con el niño antes de procesar verbalmente. Después pregunte: «¿Cómo estás? ¿Qué sentís ahora que no estaba antes?». No imponga lo que el niño debe sentir: alivio, tristeza, ambivalencia e incluso indiferencia son respuestas válidas. Lo que importa es que hubo un momento dedicado específicamente a esa despedida que la vida no ofreció.

Lectura clínica

La intensidad emocional durante el ritual de despedida varía mucho: algunos niños lloran intensamente, otros quedan en un silencio profundo, otros parecen más livianos de lo esperado. No interprete la ausencia de llanto como ausencia de elaboración. Observe la calidad del estado después del ritual: un niño que parece más liviano, más presente, o que hace comentarios de cierre («creo que ahora lo dije») demuestra que el ritual cumplió su función. Un niño que queda muy activado y no logra regularse después necesita más tiempo de regulación y puede indicar que el trabajo de duelo traumático precede a este ritual. Si el niño fue impedido por los adultos de ir al velatorio: trabaje también el enojo por esa decisión —es legítimo y a menudo no tiene espacio de expresión—.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué te hubiera gustado decirle a [nombre] si hubieras tenido la chance?
- ¿Fuiste al velatorio? Si fuiste, ¿cómo fue? Si no, ¿cómo te sentiste por no haber ido?
- ¿Hay algo que quedó sin decir o sin hacer entre ustedes que todavía pesa?
- ¿Cómo te imaginás que habría sido una despedida si hubiera ocurrido?
- Después del ritual, ¿hay algo que sentís que puede ser distinto ahora?

Adaptaciones

Para niños que fueron al velatorio pero no pudieron ver el cuerpo: trabaje específicamente la brecha entre estar presente en el ritual de despedida pero sin el contacto que confirma la muerte de forma concreta.

Para niños que no fueron al velatorio por decisión de los adultos pero que hubieran querido ir: no juzgue la decisión de la familia, pero valide la pérdida del niño. En paralelo, oriente al progenitor sobreviviente sobre la importancia de incluir al niño en los rituales de duelo de la familia en situaciones futuras.

TIPO	Ritual de cierre terapéutico — carta personalizada escrita por la psicóloga al niño
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Fase final del acompañamiento — como complemento o alternativa al cierre del recurso 20, con énfasis en la mirada externa amorosa y testimonial de la terapeuta sobre el recorrido del niño
DURACIÓN	20 minutos de lectura y procesamiento en sesión; preparación de la carta antes de la sesión
MATERIALES	La carta escrita por la psicóloga antes de la sesión de cierre, sobre especial

Objetivo

Crear un documento escrito por la psicóloga al niño —una carta personalizada que da testimonio del recorrido del duelo, nombra lo que el niño atravesó y lo que descubrió sobre sí mismo, y ofrece una mirada externa amorosa que el niño puede guardar y releer en los momentos difíciles—. La carta de la terapeuta tiene una función clínica específica que ninguna otra intervención de cierre cumple: ofrece el punto de vista de alguien que estuvo presente en todo el recorrido y que puede reflejar de vuelta, con claridad y cuidado, lo que el niño quizás no logra ver sobre sí mismo. En momentos futuros de dificultad —cuando el duelo se reactive, cuando el niño dude de sí mismo, cuando sienta que no tiene fuerza— puede releer la carta y encontrar en ella un testimonio de que ya atravesó algo muy difícil y de que tiene más recursos de los que imagina. La práctica de la carta terapéutica tiene raíces en la Terapia Narrativa de White y Epston, que la usa para externalizar y solidificar la narrativa preferida de la persona sobre sí misma.

Cómo aplicar

1

Preparación de la carta (antes de la sesión — 30 a 40 min)

La carta la escribe la psicóloga antes de la sesión de cierre. Debe incluir: una apertura que nombre lo vivido («Viniste hasta mí cargando un dolor muy grande...»), lo que la psicóloga observó en el recorrido («A lo largo de estas sesiones te vi...»), lo que el niño descubrió sobre sí mismo («Aprendiste que...»), un testimonio de lo que la psicóloga admira en el niño («Algo que tenés y que quiero que nunca olvides es...») y un mensaje para el futuro («Cuando el duelo vuelva, acordate de que...»). La carta debe estar escrita a mano o en un formato que parezca personal, no un documento clínico formal. Use el nombre del niño. Use recuerdos específicos de las sesiones. Sea concreta y genuina.

2

Entrega de la carta (5 min)

Entregue el sobre cerrado al inicio o a la mitad de la sesión de cierre. Diga: «Escribí algo para vos. No es un informe: es una carta mía para vos. Podés leerla ahora conmigo o llevarla para leer en casa. La elección es tuya». Respete la elección del niño: ambas formas tienen valor.

3

Lectura y procesamiento (15 min)

Si el niño elige leerla en sesión, léanla juntos o deje que la lea en silencio mientras usted permanece presente. Después de la lectura, quédese en silencio un momento. Después pregunte solo: «¿Cómo estás?». No interprete la carta de vuelta: ya habló por sí misma. Acoja lo que emerja: llanto, silencio, sorpresa, alegría, o simplemente un «gracias» que carga más de lo que las palabras logran expresar.

El destino de la carta (5 min)

Conversen sobre dónde va a guardar el niño la carta: junto con los otros materiales del proceso, en la caja de recuerdos, en el cuarto, en la mochila. Sugiera que la relea cuando el duelo se reactive, cuando dude de sí mismo, cuando necesite un recordatorio de que ya atravesó algo muy difícil. Cierre con una frase que sea suya —no de un protocolo— sobre lo que fue este tiempo juntos.

Lectura clínica

La carta de la terapeuta es uno de los documentos de mayor impacto del cierre porque viene de una fuente externa en la que el niño aprendió a confiar a lo largo del proceso. Observe la reacción del niño al recibir y leer la carta: un niño que llora al leerla suele estar siendo tocado por ver su propia historia reflejada con cuidado —la carta está espejando algo que sabía pero que nunca había visto escrito sobre sí mismo—. Un niño que queda en silencio profundo está absorbiendo. Un niño que pregunta «¿de verdad pensás eso?» revela que la autoestima todavía necesita anclaje externo —la carta cumple esa función de forma duradera porque puede releerse—. Escribir la carta es también un ejercicio clínico para la psicóloga: exige reflexionar sobre el recorrido del niño con cuidado y especificidad, lo que a menudo revela avances que no se celebraron explícitamente en el proceso.

Preguntas orientadoras

- ¿Cómo estás después de leer la carta?
- ¿Había algo en la carta que no sabías que yo veía en vos?
- ¿Hay algo que te hubiera gustado que estuviera en la carta y no estaba?
- ¿Dónde vas a guardar la carta? ¿Cuándo la vas a releer?
- ¿Hay algo que quieras decirme antes de despedirnos?

Adaptaciones

Para niños que piden escribir una carta de vuelta para la terapeuta: recíbala con cuidado y alegría —ese gesto es uno de los más lindos que pueden ocurrir en un cierre, y la carta del niño para la terapeuta es un documento clínico precioso del desenlace del proceso—.

Para situaciones de cierre no planificado (mudanza, fin de cobertura, circunstancias externas): la carta es aún más importante porque el cierre no tuvo la preparación ideal. Cumple la función de dar sustancia a un final que las circunstancias volvieron abrupto.